

皮膚良性腫瘍・母斑・母斑症を読み解く 病態、診断、治療のすべて

名古屋市立大学大学院医学研究科 加齢・環境皮膚科 講師

真柄徹也

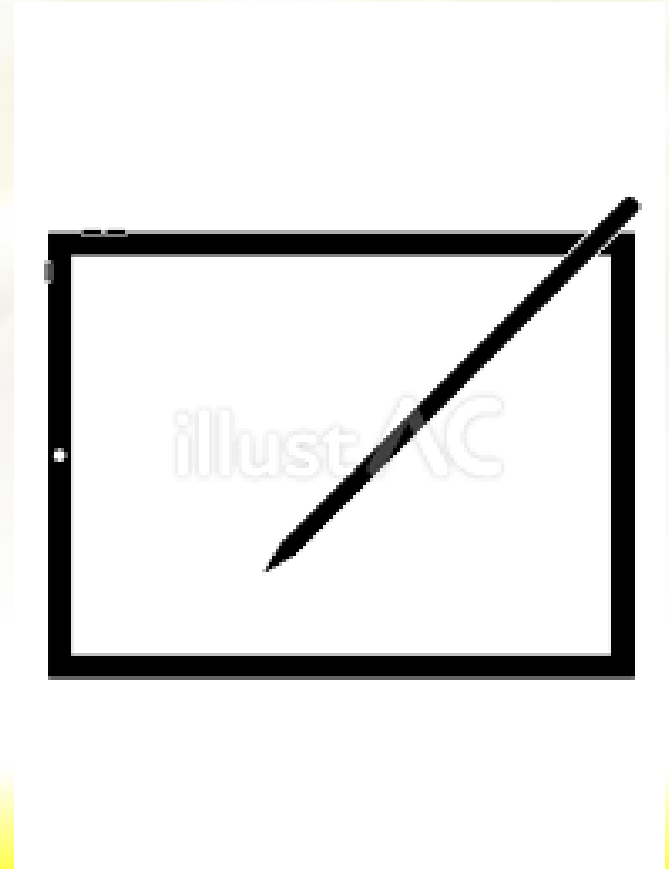


皮膚良性腫瘍・母斑・母斑症を読み解くために

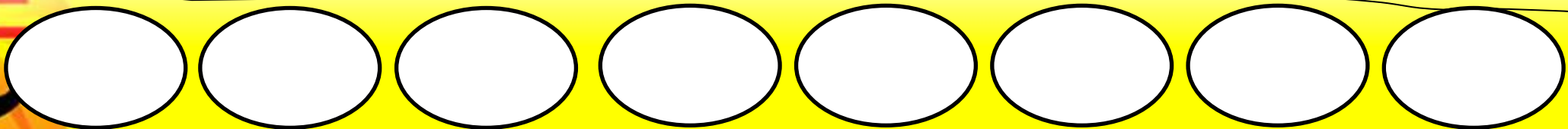
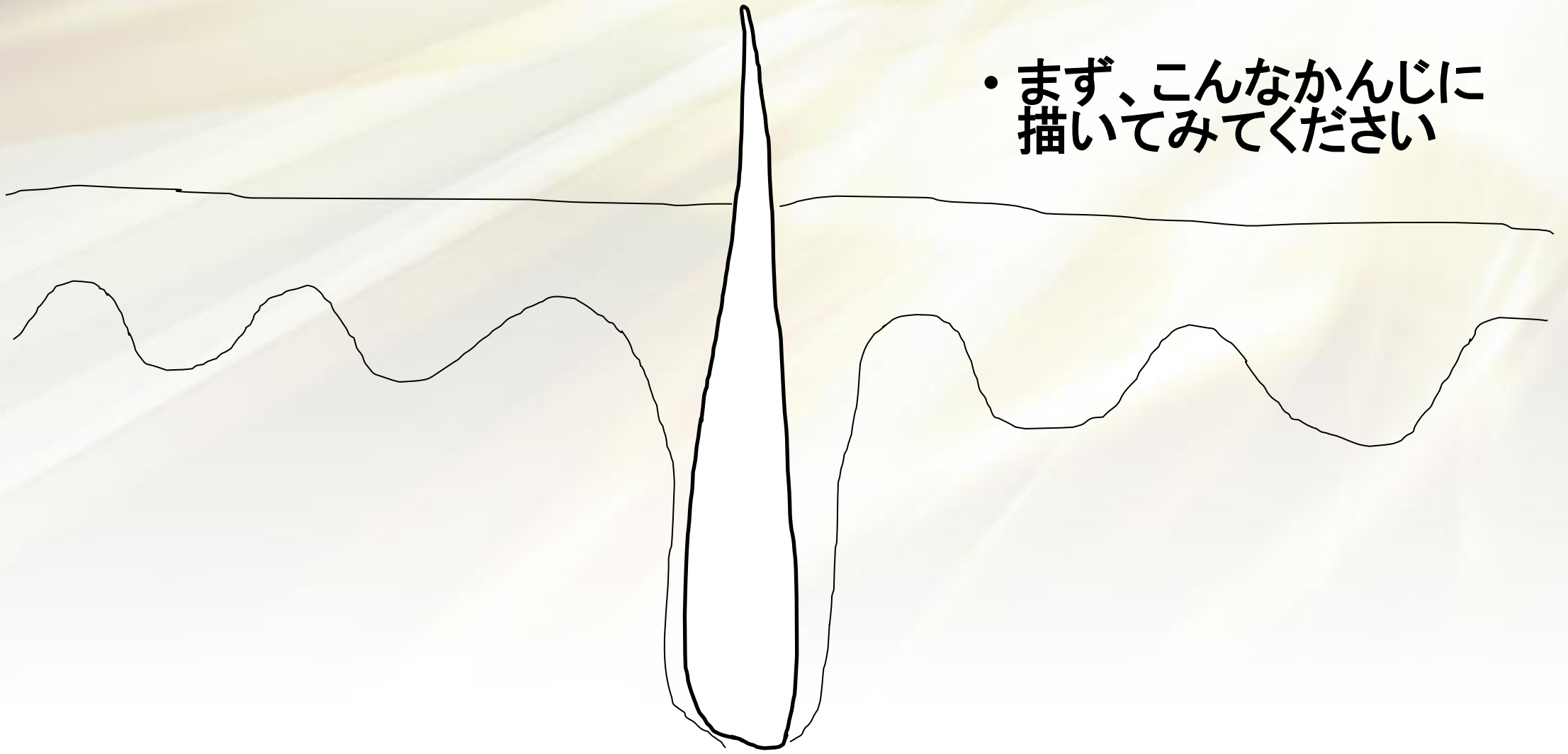
皮膚を描けるようになる① なまえ当てクイズ



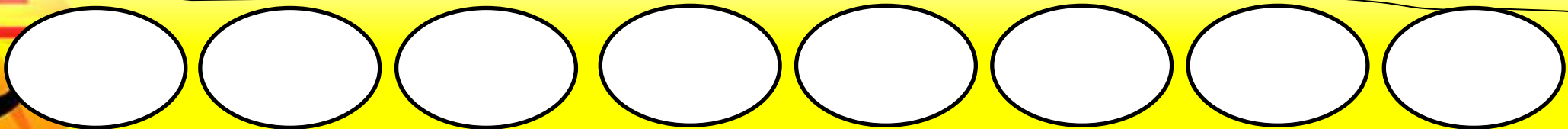
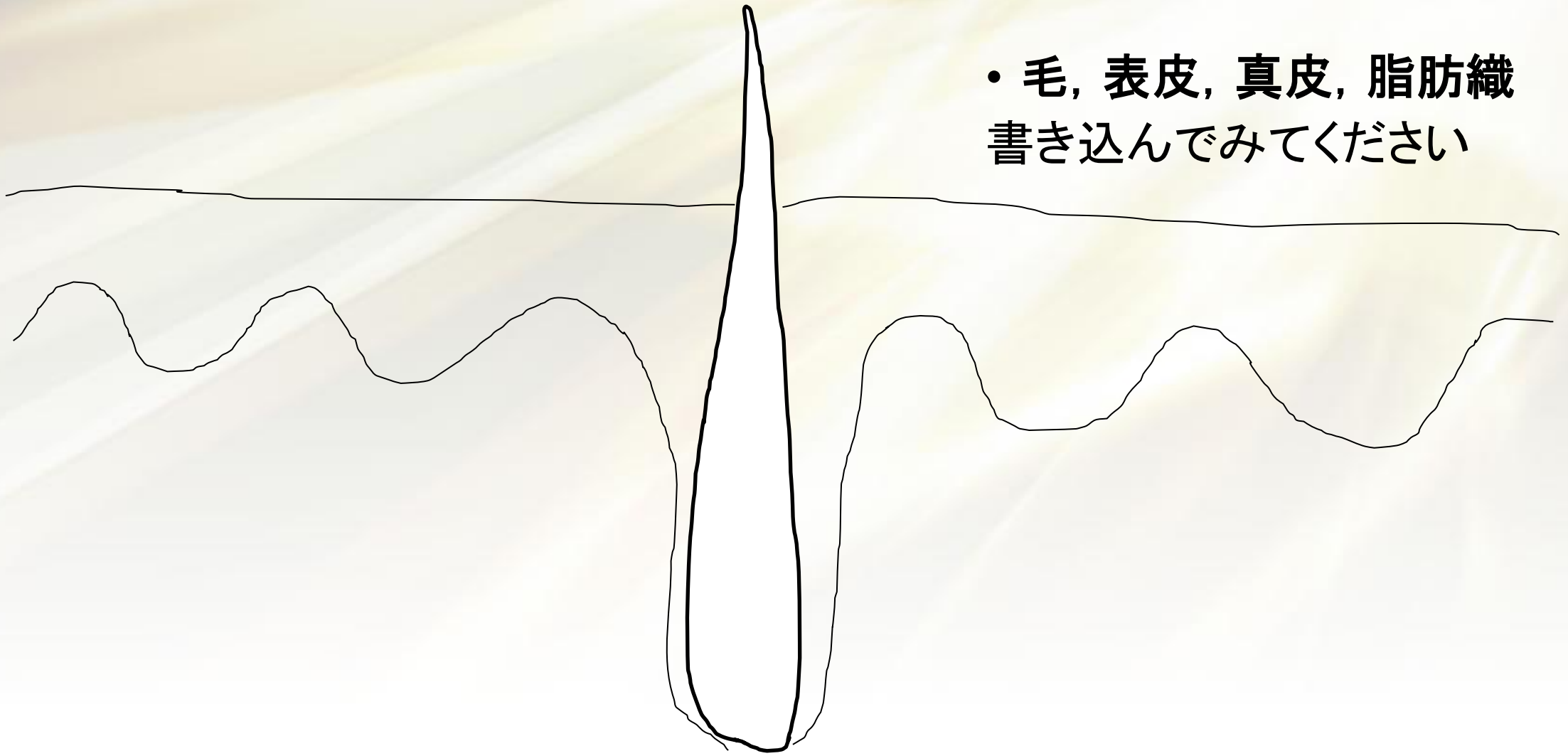
書くものを用意できますか？

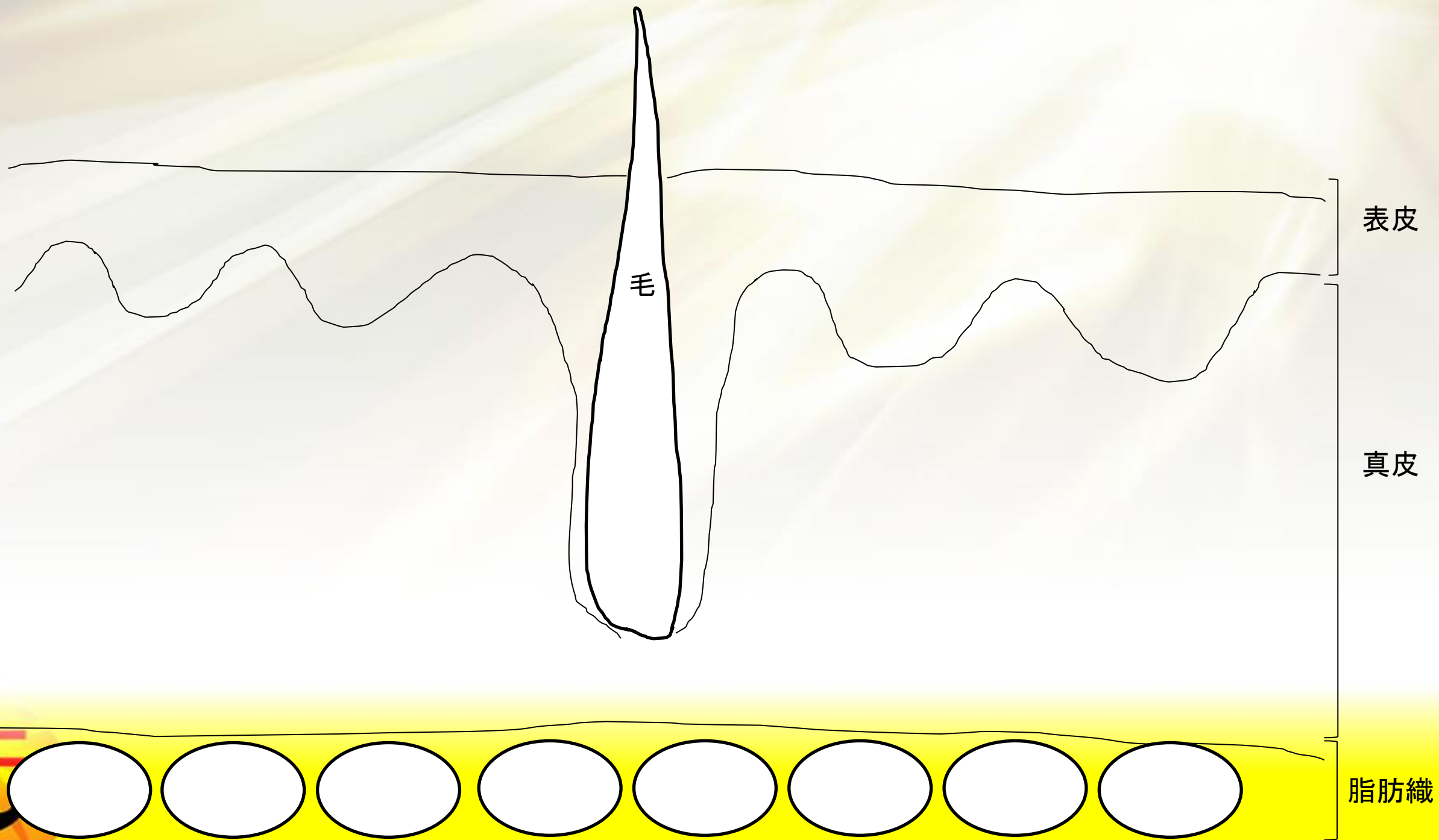


・まず、こんなかんじに
描いてみてください

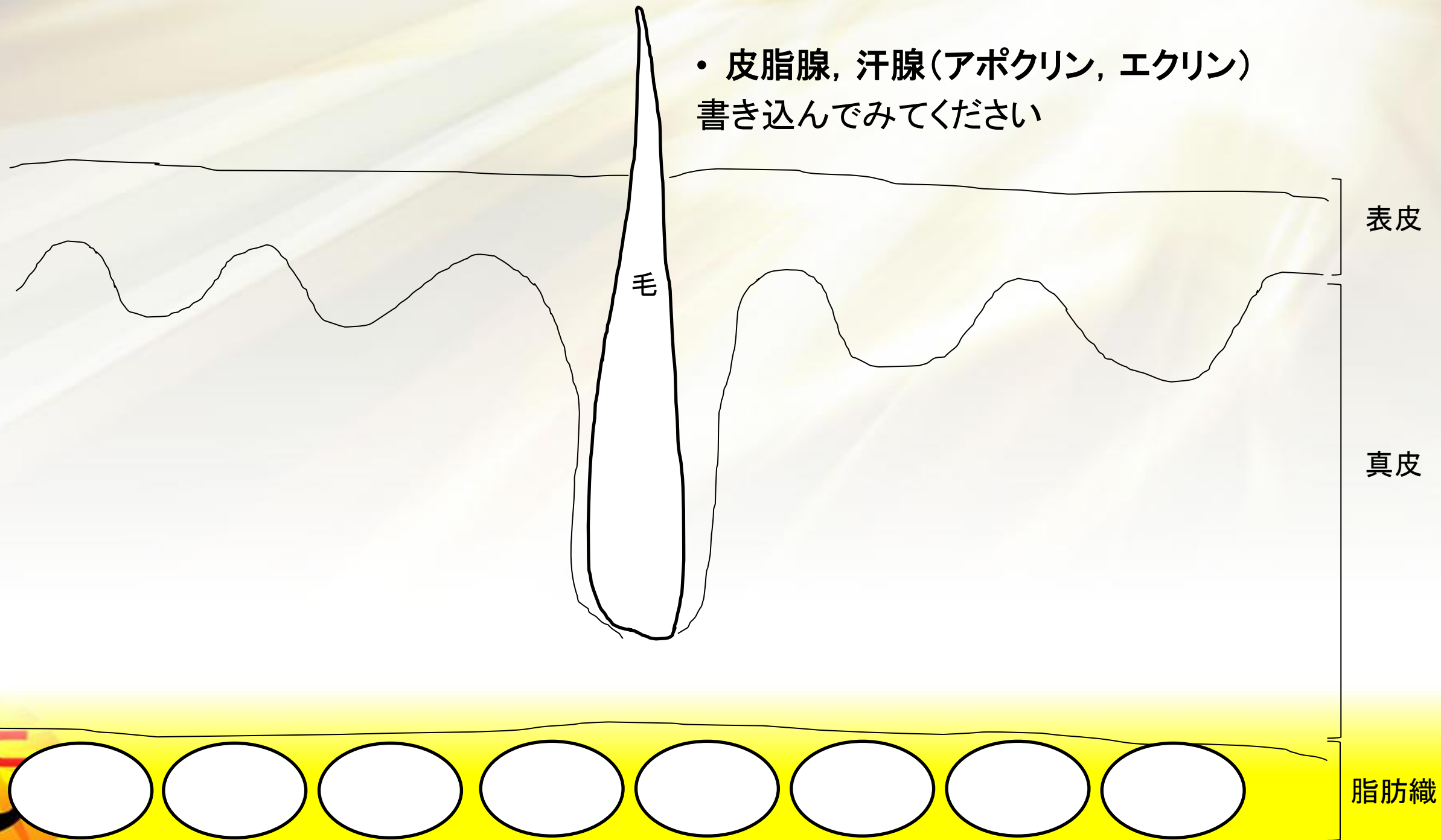


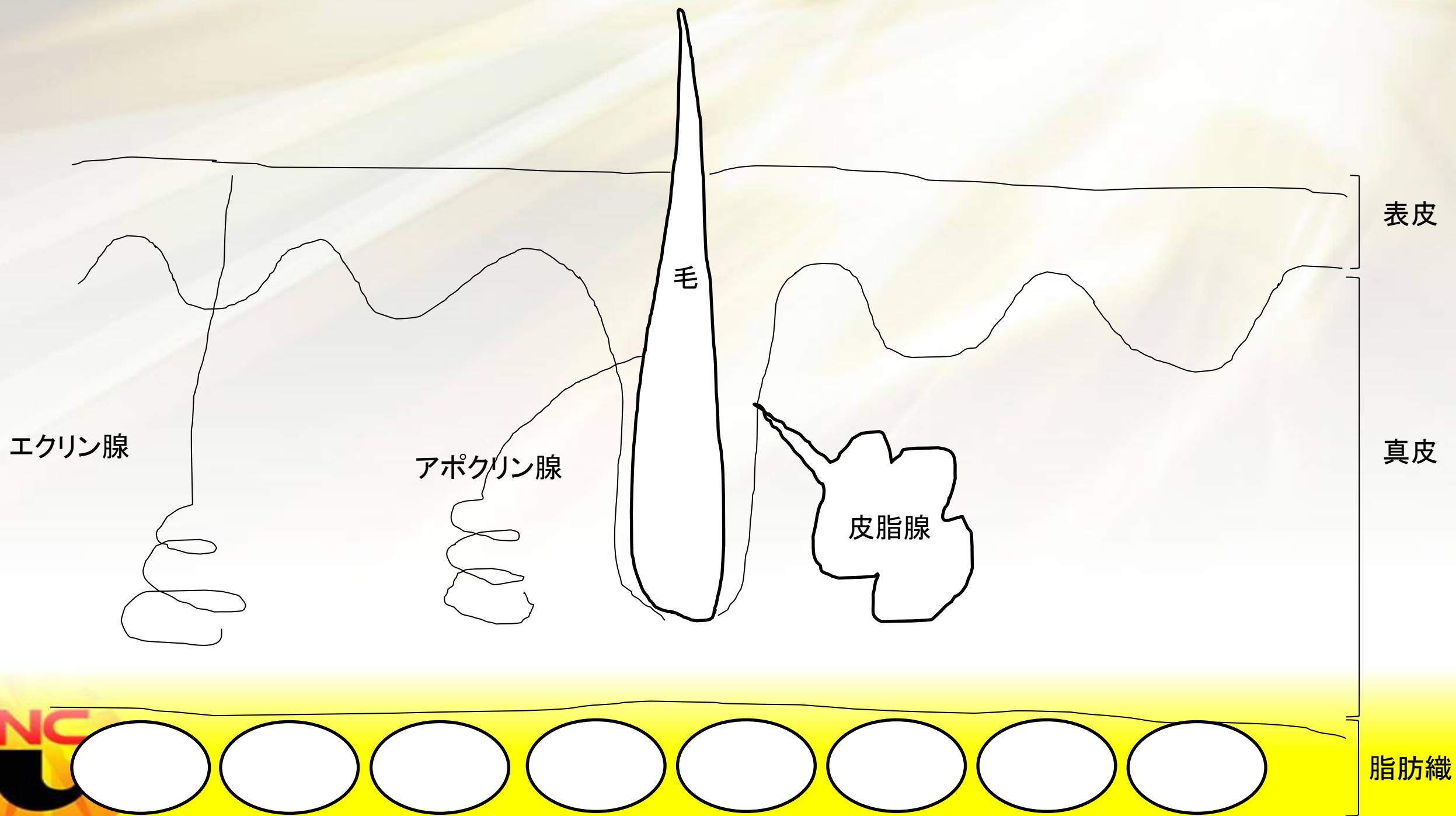
・毛, 表皮, 真皮, 脂肪織
書き込んでみてください





- 皮脂腺, 汗腺(アポクリン, エクリン)
書き込んでみてください





エクリン腺

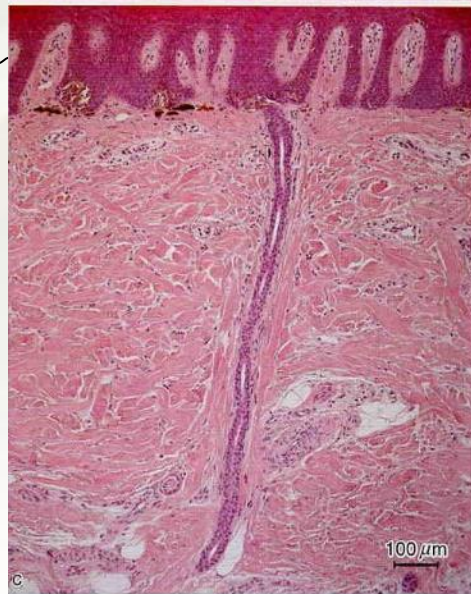
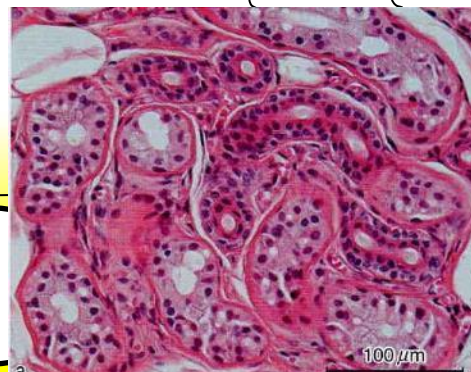
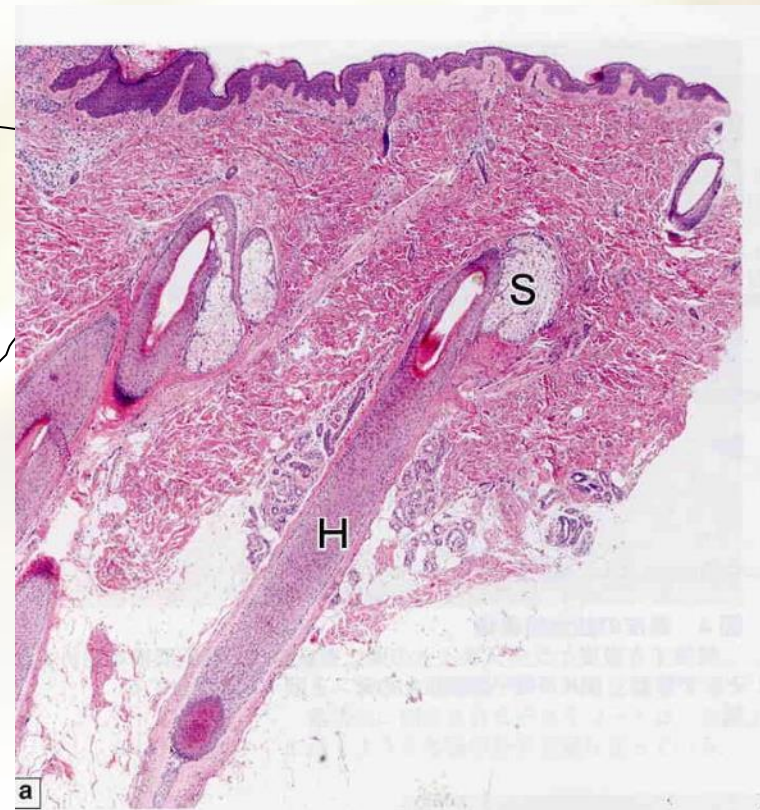


図 1.45 エクリン汗腺 (eccrine sweat gland)



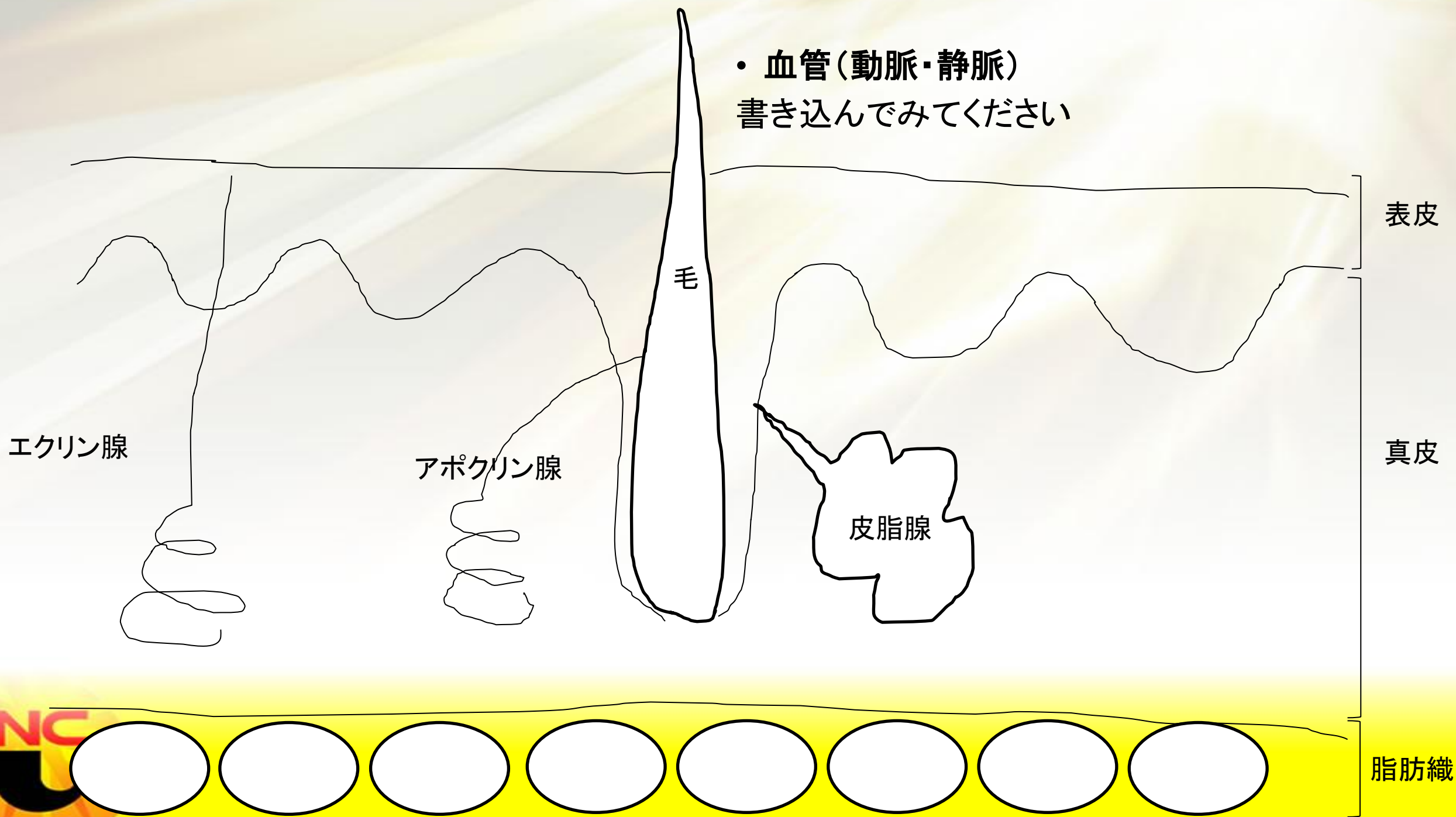
毛

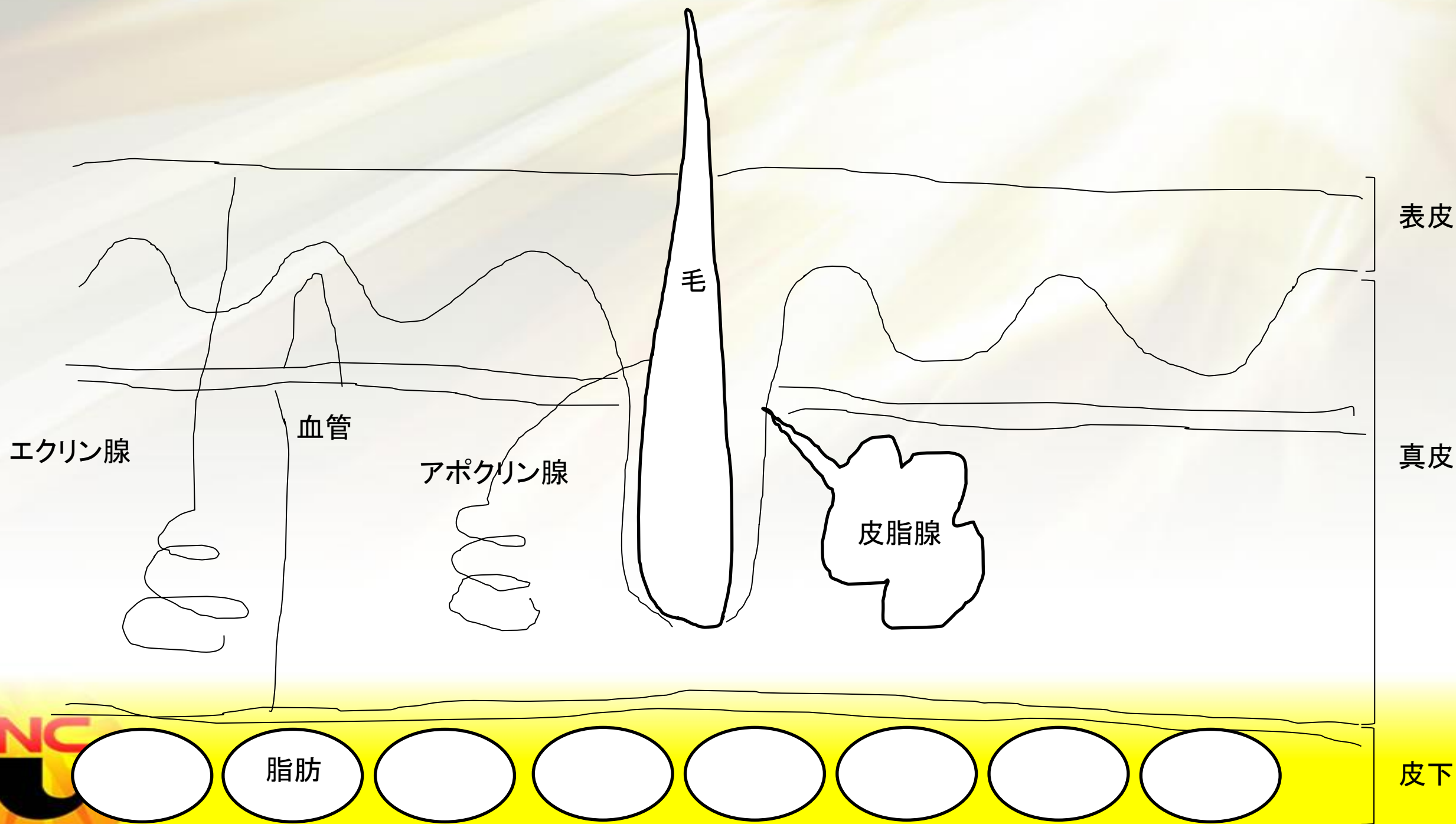
皮脂腺

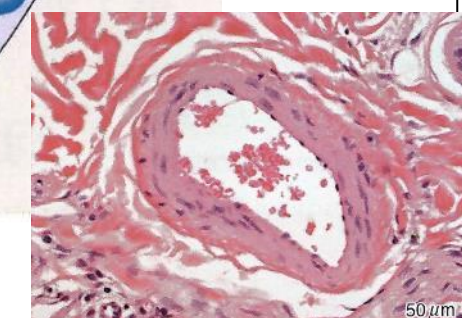
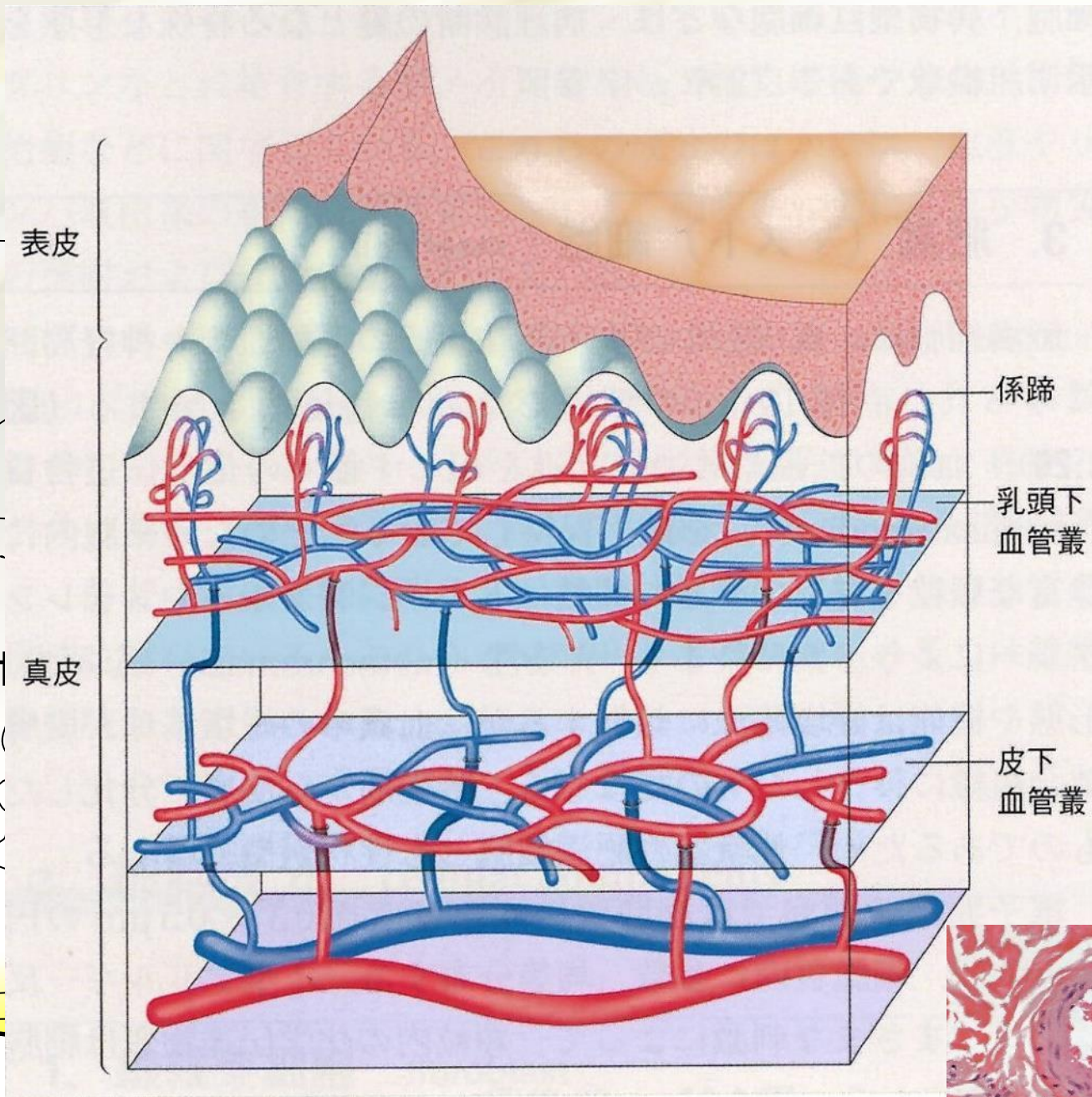


脂肪織

• 血管(動脈・静脈)
書き込んでみてください







皮下

図 1.32 表皮下の血管配置

なんとなく、
わかるように
になりましたか？

あたらしい皮膚科
学第3版から引
用しています

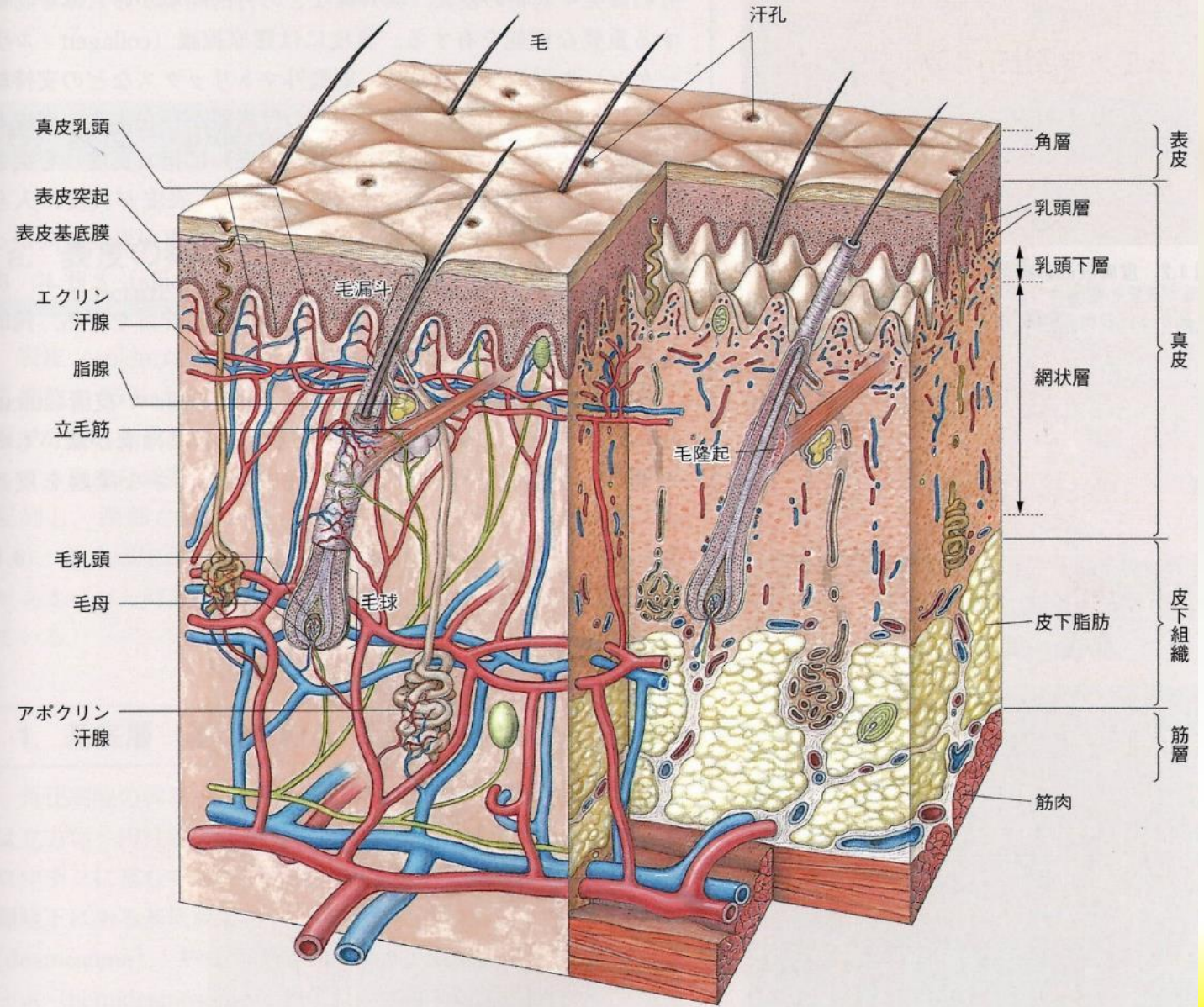


図 1.1 皮膚模式図

皮膚を描けるようになる②

次は表皮です

・以下の要素を含むこと

基底膜, 基底層, 有棘層, 顆粒層, 角層
メラノサイト(色素細胞), ランゲルハンス細胞



基底層，有棘層，顆粒層，角層

基底膜



有棘層，顆粒層，角層

基底層(基底細胞層)

基底膜

顆粒層, 角層

有棘層(有棘細胞層)

基底層(基底細胞層)

基底膜

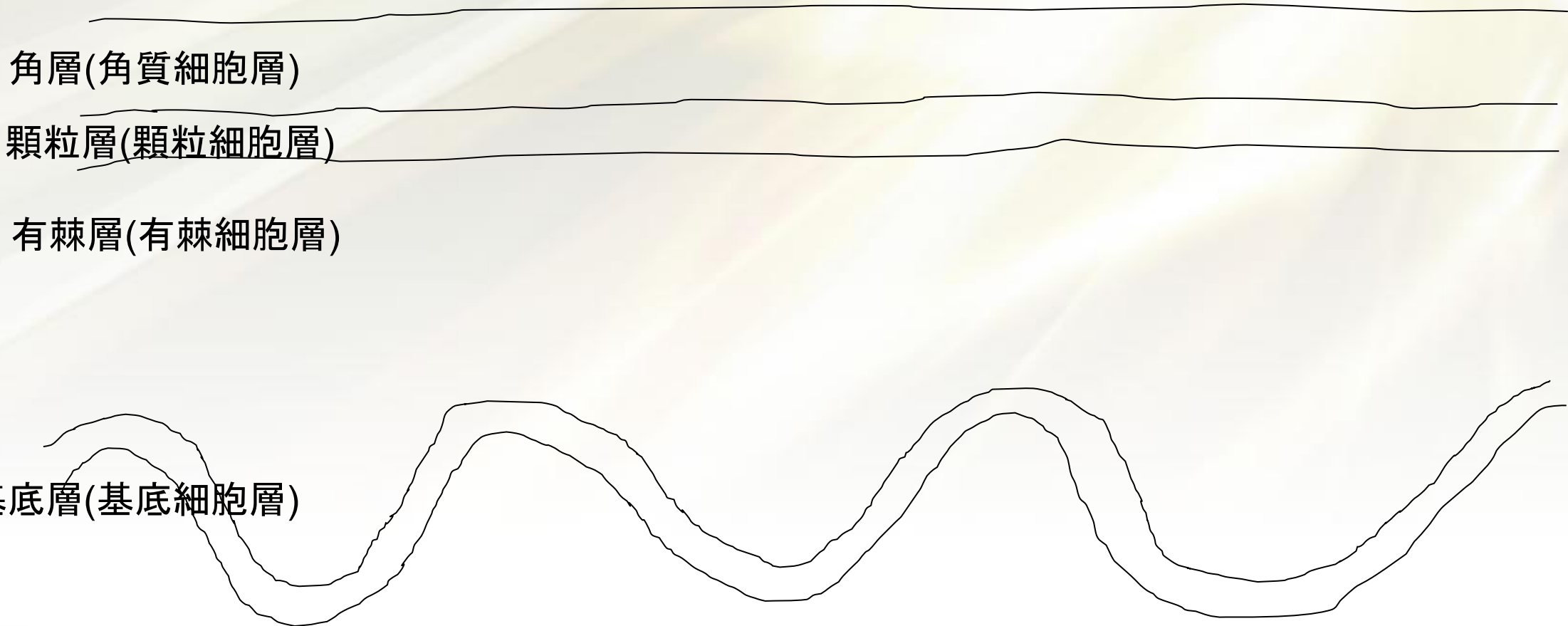
角層

顆粒層(顆粒細胞層)

有棘層(有棘細胞層)

基底層(基底細胞層)

基底膜



A hand-drawn diagram of the skin layers. It consists of four horizontal layers. The top layer is the thinnest. The second layer is slightly thicker. The third layer is the thickest and contains several small, dark, irregular shapes representing keratin granules. The bottom layer is a thin, wavy line. The layers are labeled from top to bottom: 角層(角質細胞層), 顆粒層(顆粒細胞層), 有棘層(有棘細胞層), and 基底層(基底細胞層).

角層(角質細胞層)

顆粒層(顆粒細胞層)

有棘層(有棘細胞層)

基底層(基底細胞層)

角層(角質細胞層)

顆粒層(顆粒細胞層)

有棘層(有棘細胞層)

基底層(基底細胞層)

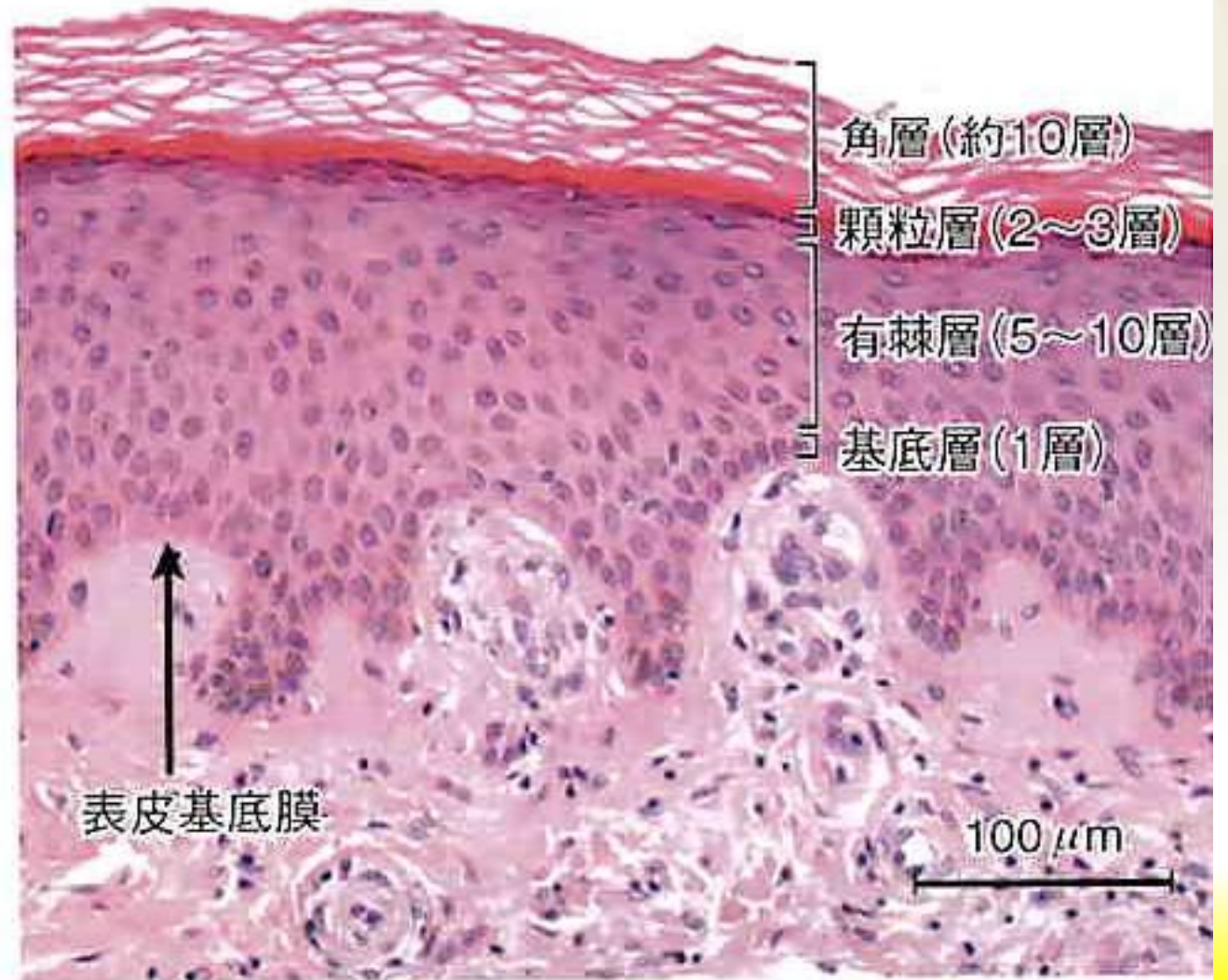


図 1.5 表皮を構成する細胞の 4 層構造

- ・メラノサイト、ランゲルハンス細胞
書き込んでみてください

角層(角質細胞層)

顆粒層(顆粒細胞層)

有棘層(有棘細胞層)

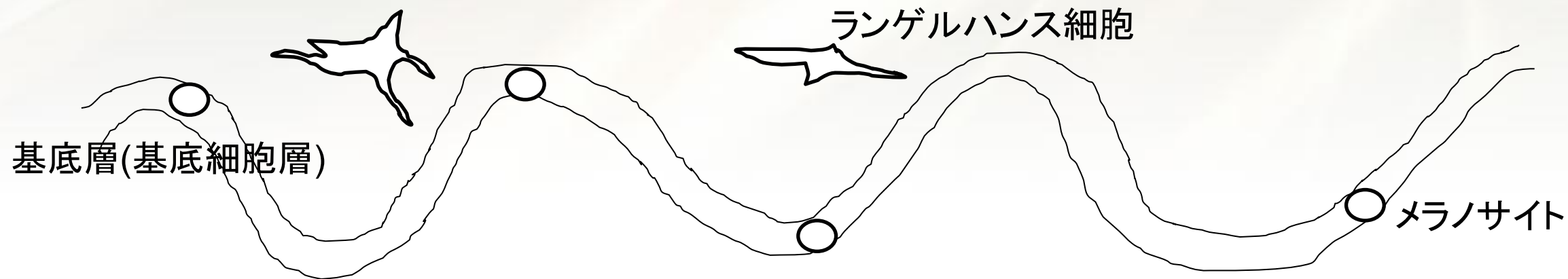
基底層(基底細胞層)



角層(角質細胞層)

顆粒層(顆粒細胞層)

有棘層(有棘細胞層)



角層(角質細胞層)

顆粒層(顆粒細胞層)

有棘層(有棘細胞層)

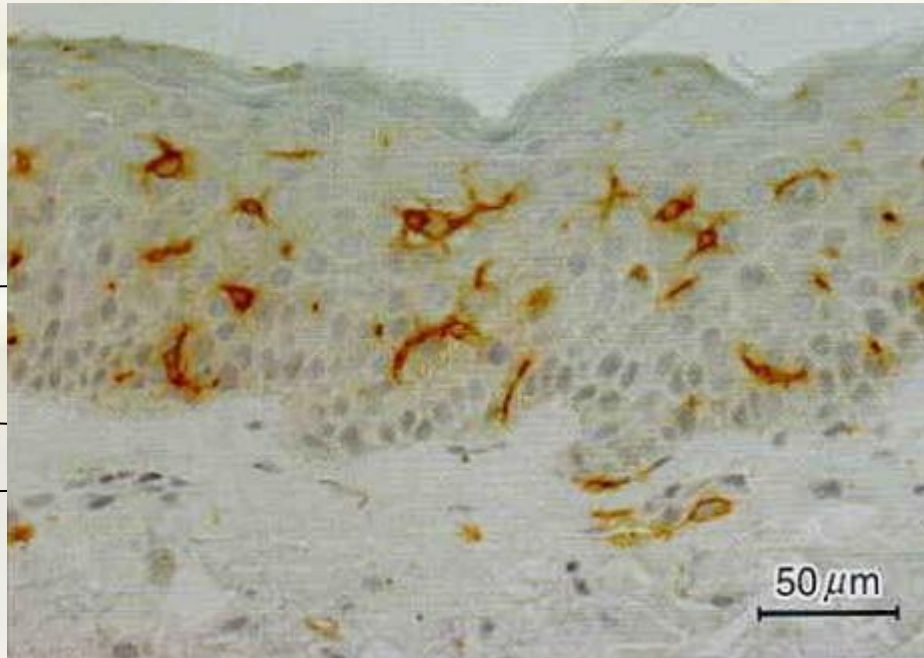


図 1.22 Langerhans 細胞 (CD1a 染色)

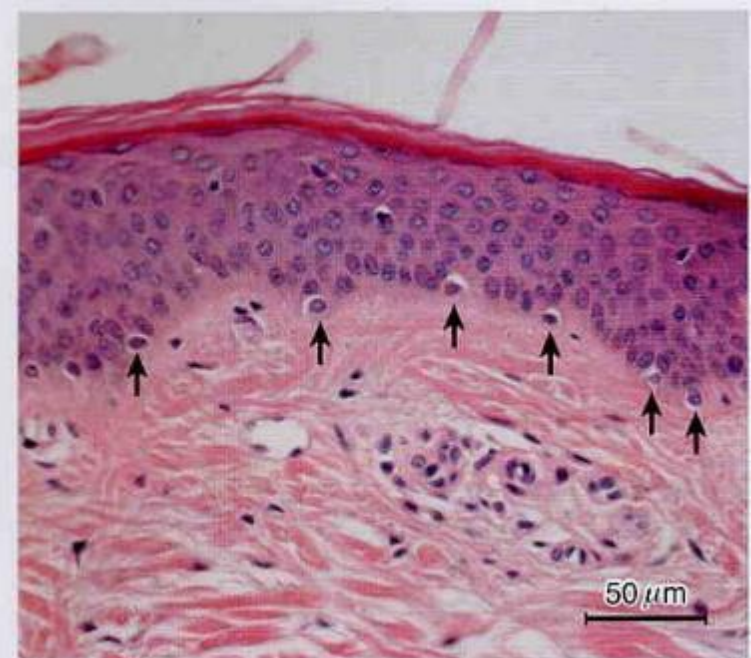
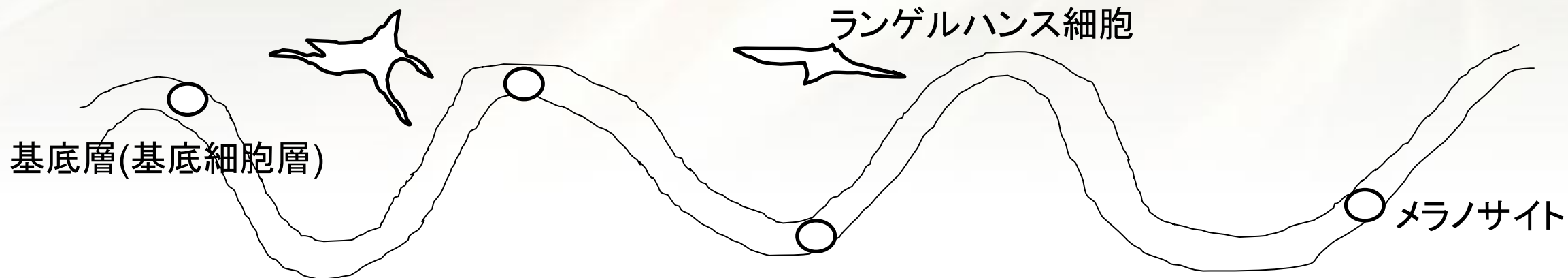


図 1.19 メラノサイト (melanocyte)



皮膚を描けるようになる③

真皮にいる細胞たち

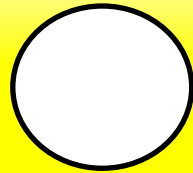
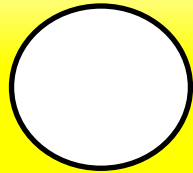
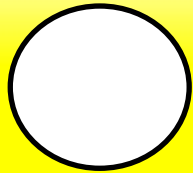
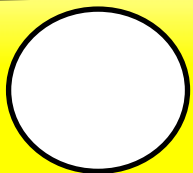
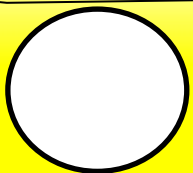
線維芽細胞、膠原線維，弾性線維，
神経，リンパ管
組織球，リンパ球，肥満(マスト)細胞，
形質細胞



ちょっと横に足しました



これらは何でしょう



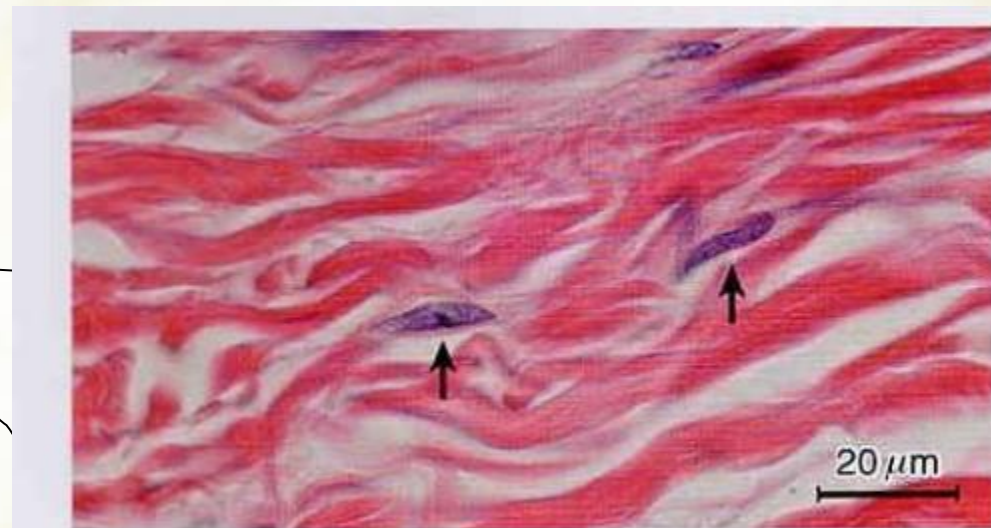
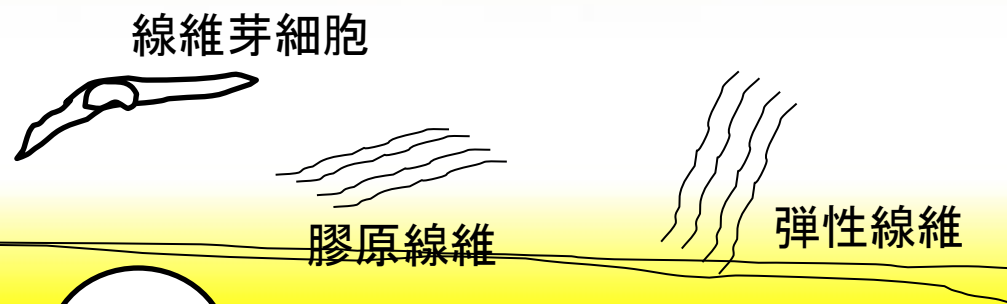


圖 1.27 線維芽細胞 (fibroblast)



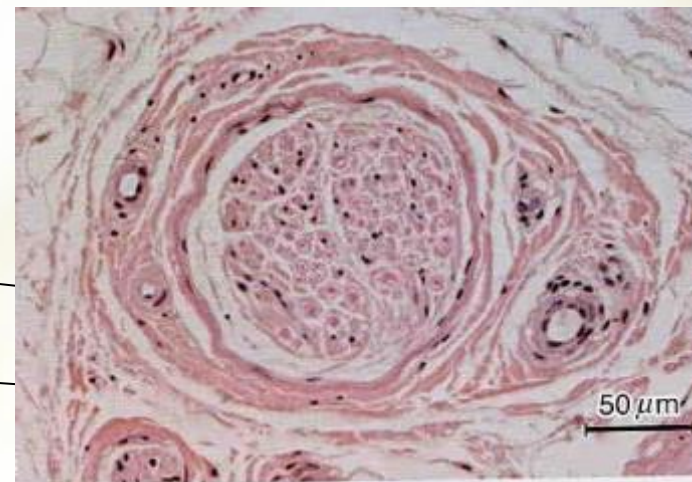
これは何でしょう

線維芽細胞

膠原線維

弾性線維

神經



線維芽細胞



膠原線維



彈性線維

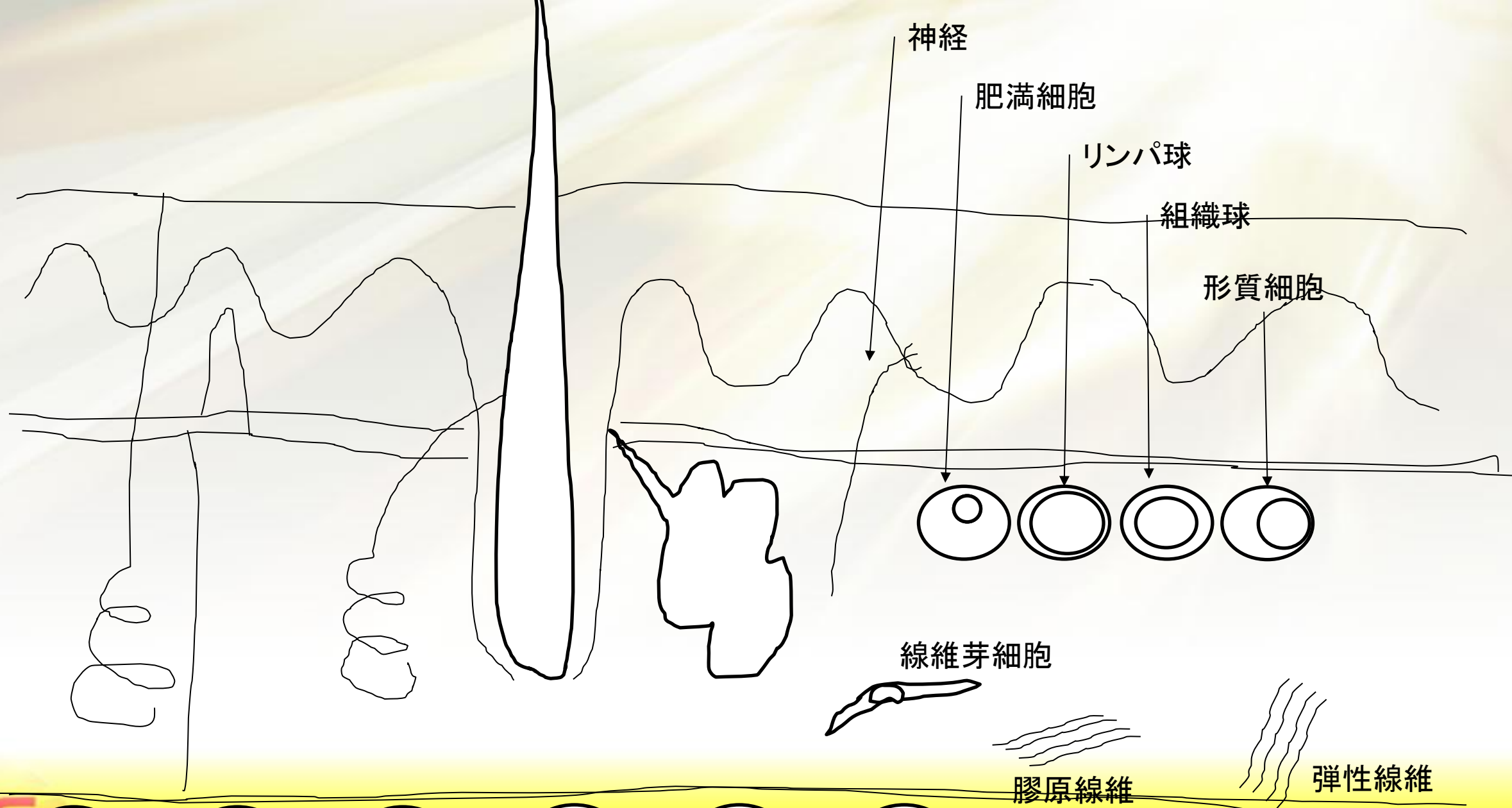
神経

これらは何でしょう

線維芽細胞

膠原線維

弾性線維



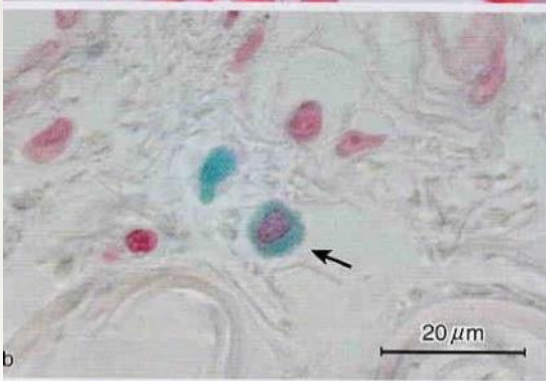
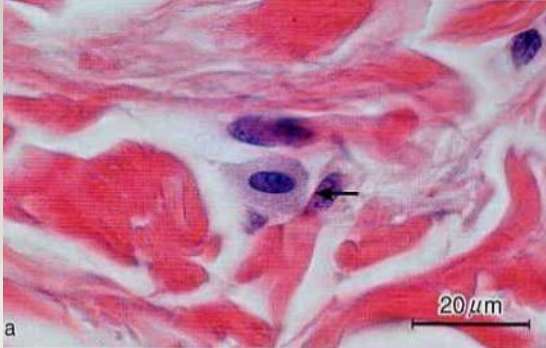


図 1.29 肥満細胞 (mast cell)
a: HE 染色. b: トルイジンブルー染色による異染色性.

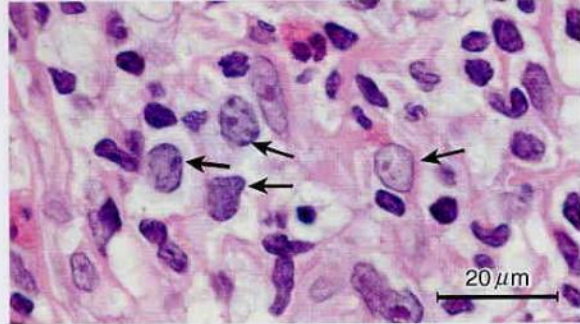


図 1.28 組織球 (histiocyte)

組織球, 単球, マクロファージ

MEMO

食食作用をもつ生体内の大型細胞をマクロファージ (macrophage) というが、これらは大きく2種類に大別される。

- ・遊走性マクロファージ (free macrophage) : 血中の単球 (monocyte), 肉芽腫で遊走してきたマクロファージなど。
- ・定着性マクロファージ (fixed macrophage) : 真皮・皮下の組織球 (histiocyte), Kupffer 細胞など。

すなわち、組織球, 単球はマクロファージの一種といえる。

メラノファージ

MEMO

表皮から真皮に滴落したメラニン顆粒は組織球により捕食されることが多い。捕食を繰り返し、茶褐色に観察されるようになった組織球のことをメラノファージ (melanophage) と呼ぶ。

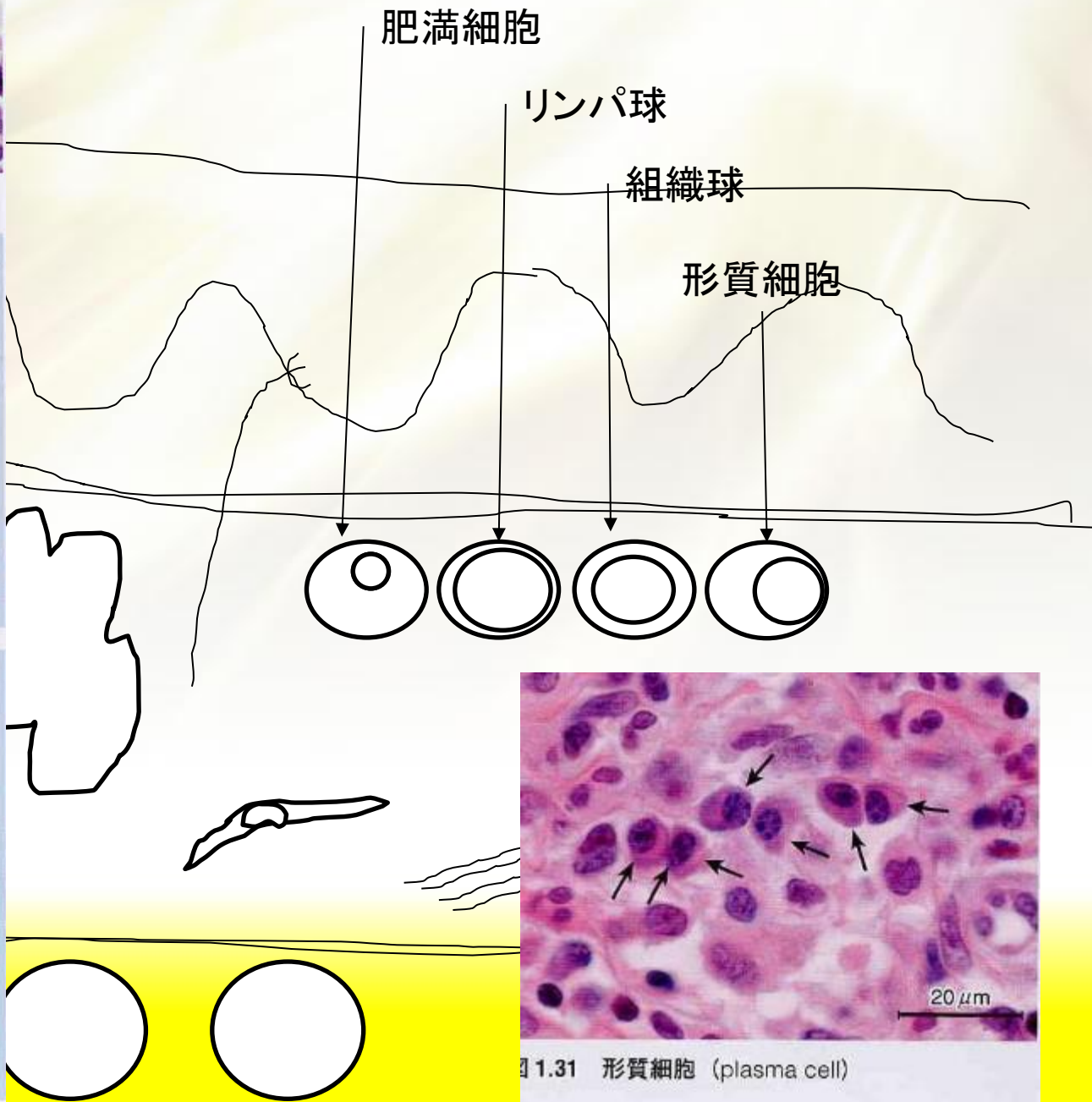
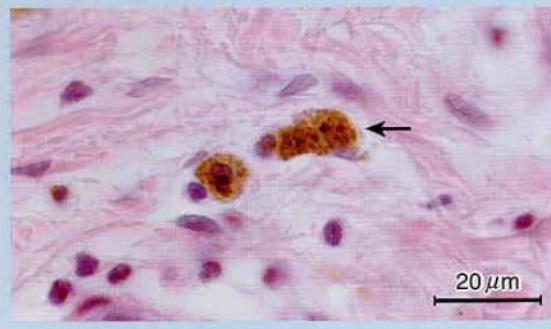
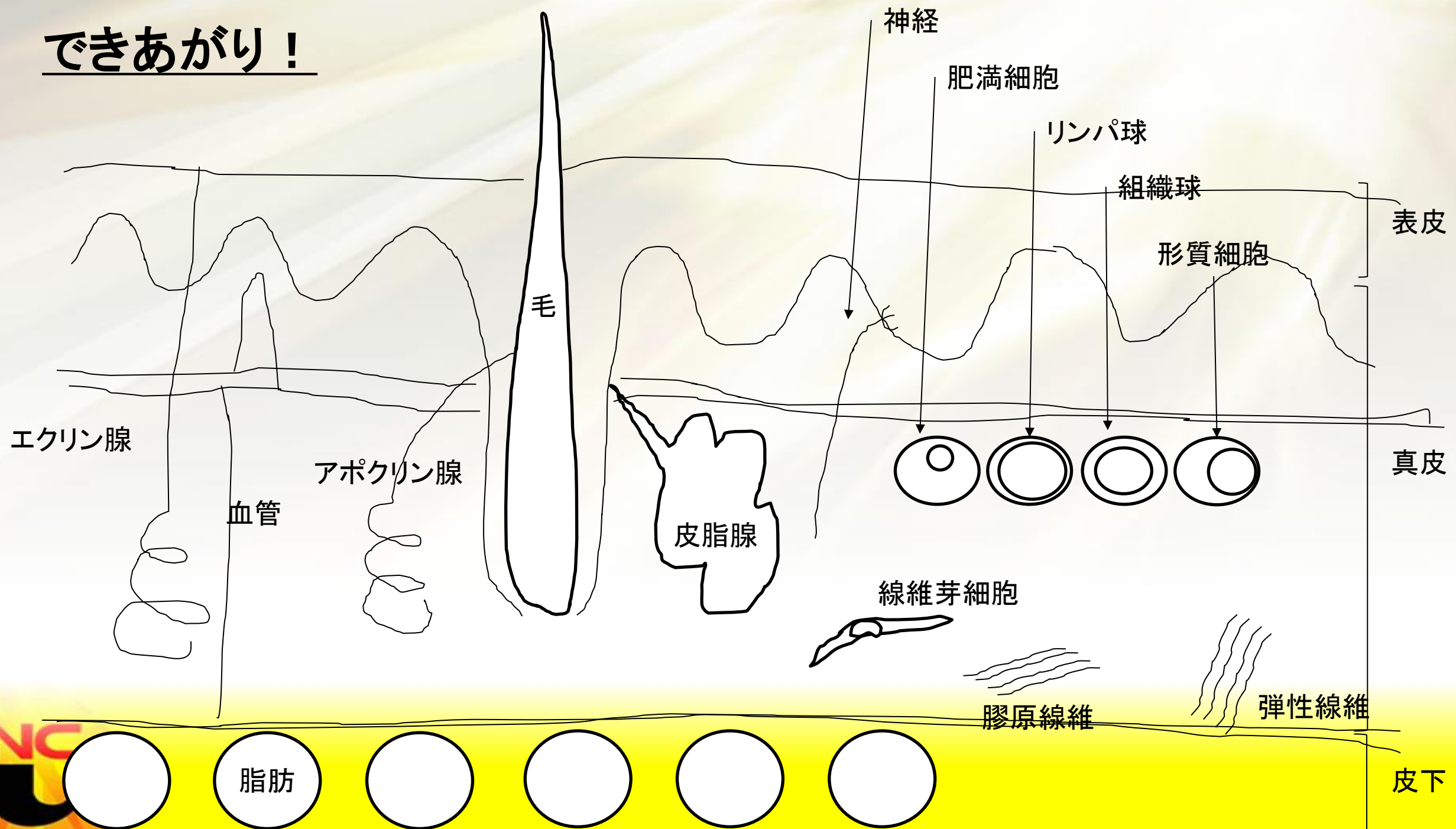


図 1.31 形質細胞 (plasma cell)

できあがり！



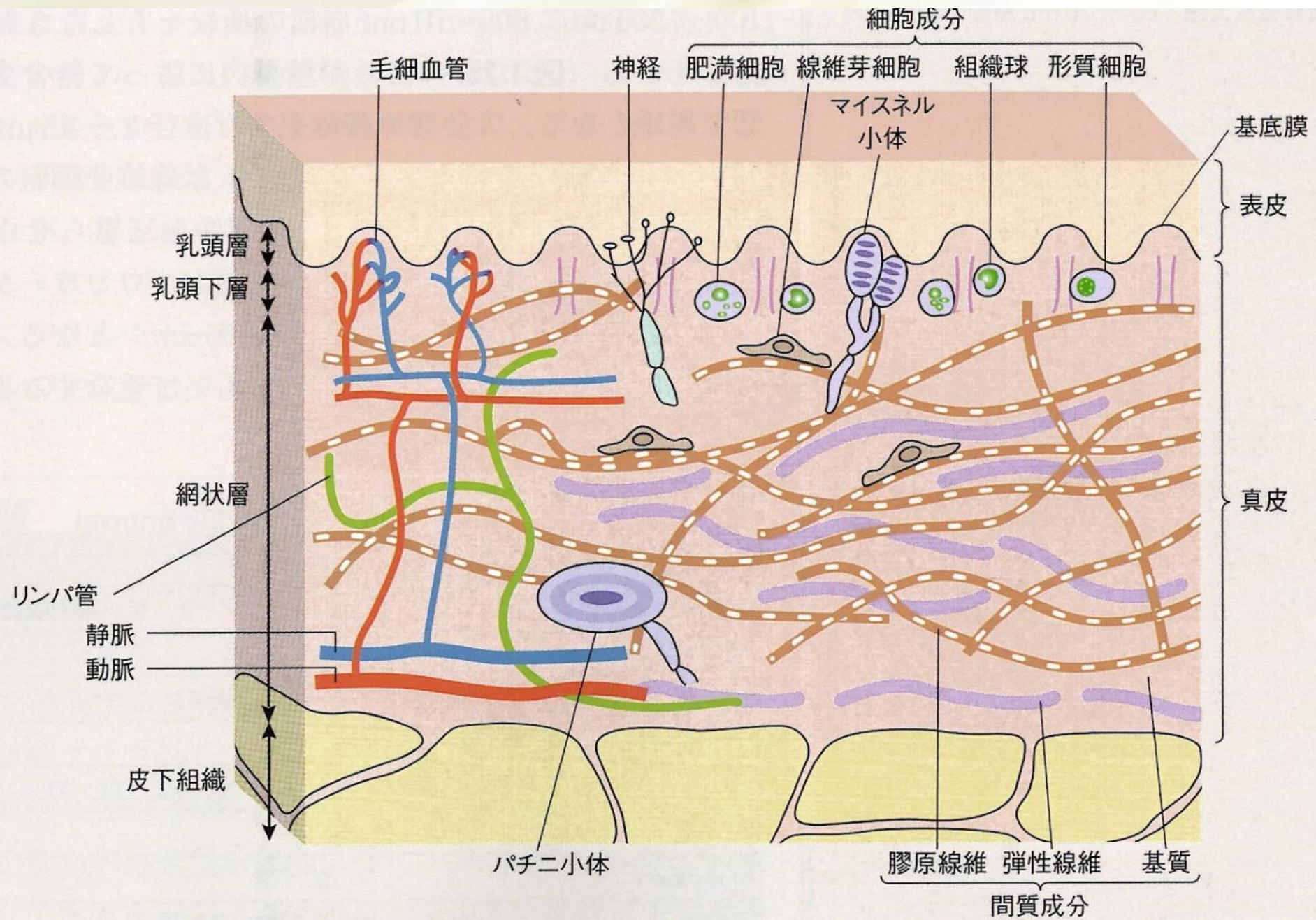


図 1.24 真皮の構造（間質成分，細胞成分，血管，リンパ管，神経）

第120回 医師国家試験 C30

Q 表皮内に存在するのはどれか。

- a. 皮脂腺
- b. 肥満細胞
- c. 毛母細胞
- d. 線維芽細胞
- e. Langerhans細胞



皮膚の良性腫瘍

どうして、これを勉強したかというと



腫瘍の元になる細胞，組織を理解する
と，ちょっとわかりやすいから





図 21.1① 脂漏性角化症 (seborrheic keratosis)
高齢者の背部に多発した褐色から黒褐色の 1 ～ 2 cm 大の角化性、扁平性隆起性皮疹。

図 21.1② 脂漏性角化症 (seborrheic keratosis)
皮膚面に粘土細工を貼りつけたような外観を呈する。表面は角化性で乳頭状である。

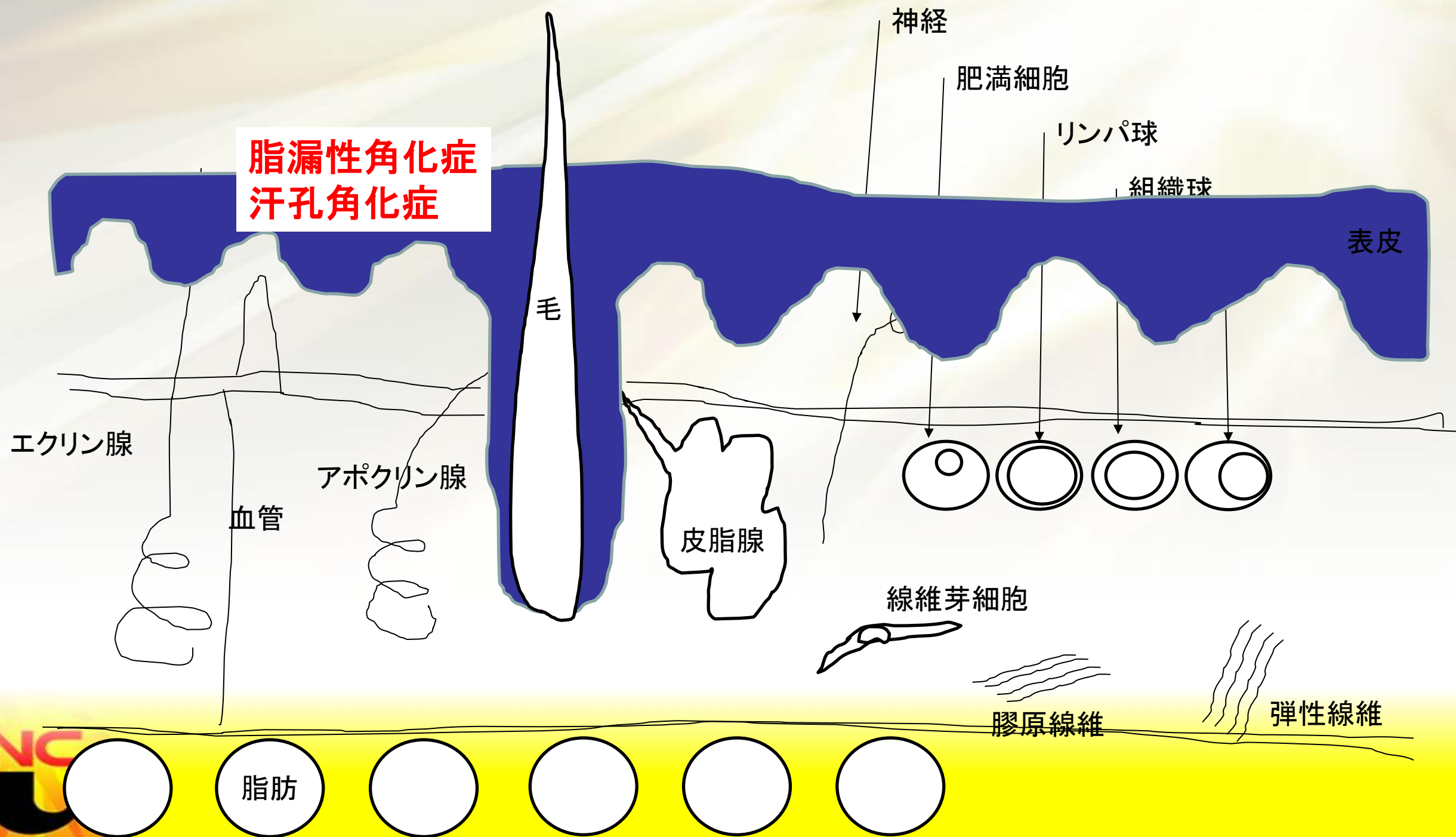
しろうせいかくかしょう



図 21.3① 汗孔角化症 (porokeratosis)

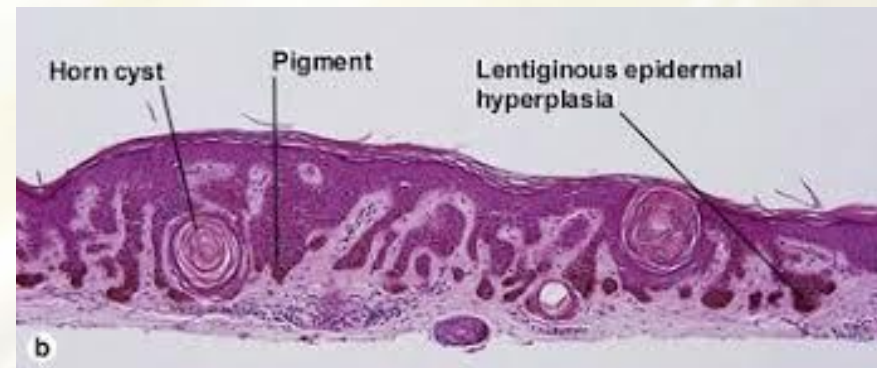
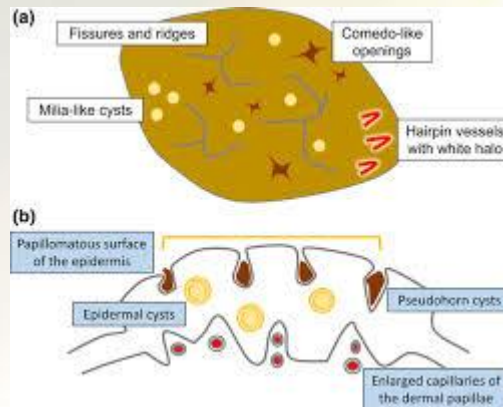
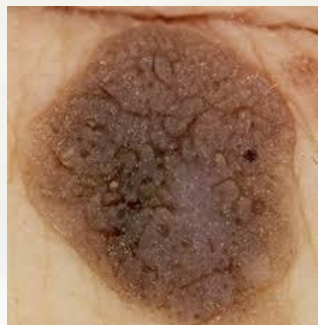
かんこうかくかしょう

脂漏性角化症
汗孔角化症



診断 脂漏性角化症＝老人性疣贅（ゆうぜい）

視診，ダーモスコピー（Dermoscopy），生検



治療

- ①冷凍凝固療法（液体窒素）
- ②レーザー療法（炭酸ガス）
- ③手術療法

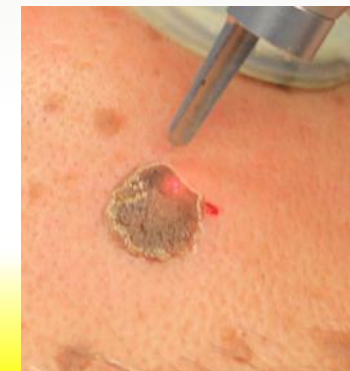




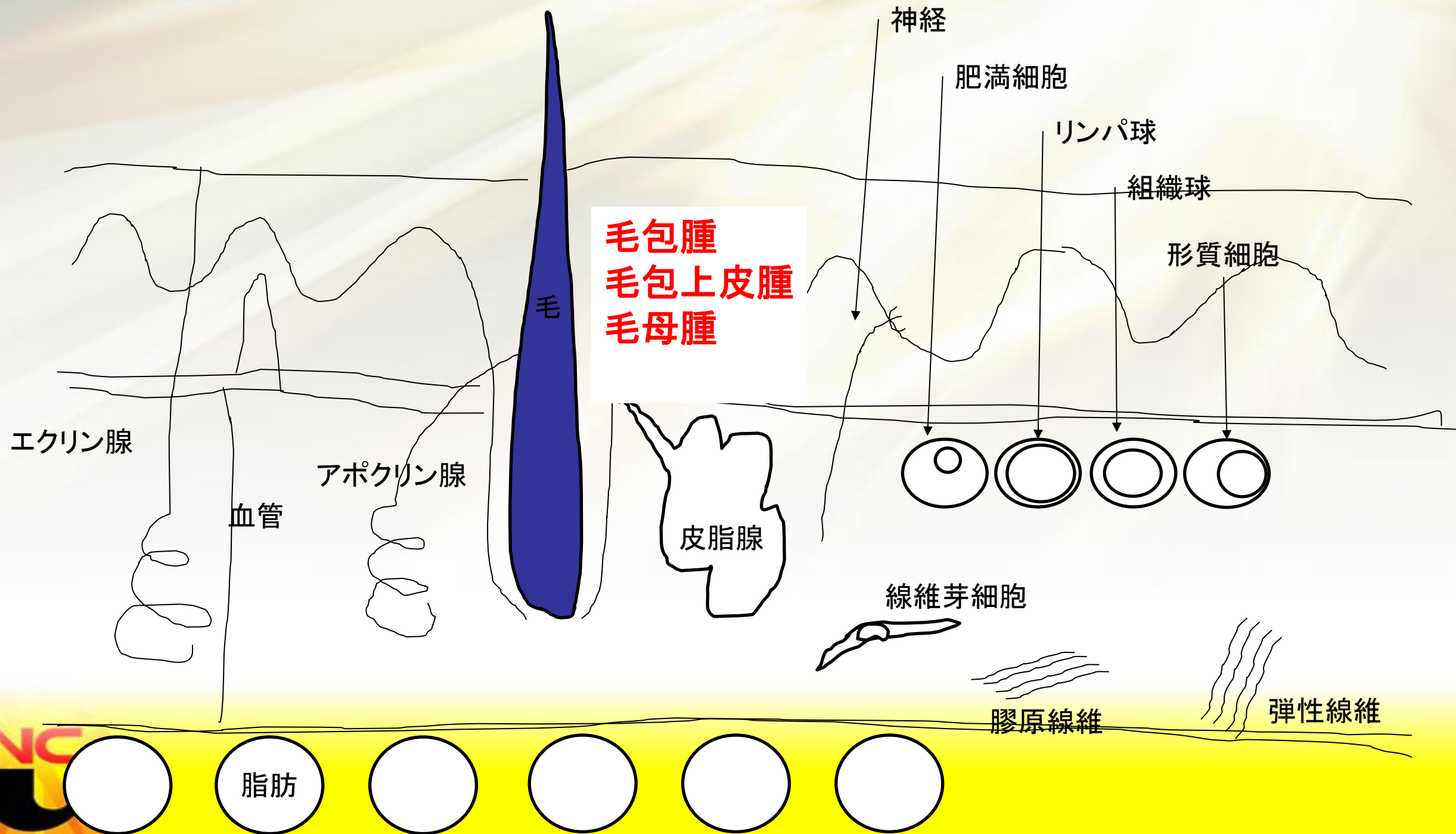
図 21.5 毛包腫 (trichofolliculoma)
中央部に角化性小陥凹がみられ、複数の幼弱毛が生えている。



図 21.6 多発性家族性毛包上皮腫 (multiple familial trichoepithelioma)
正常皮膚色, 2~10 mm 大の半球状の硬い丘疹が多発。



図 21.8 毛母腫 (pilomatricoma)
直径 1 ~ 2 cm の軽度圧痛を伴う皮下結節。水疱形成や淡紅斑を伴うこともある。



毛包腫，毛母腫

診断

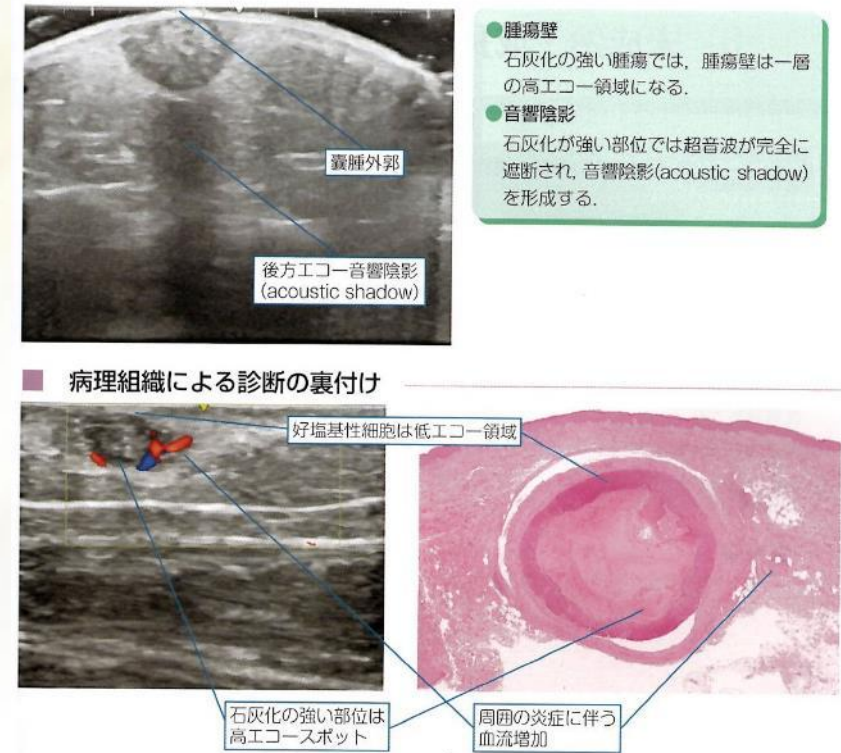
視診，生検

エコー（皮下腫瘍）

治療

①手術療法

②レーザー療法（炭酸ガス）（小さいもの）



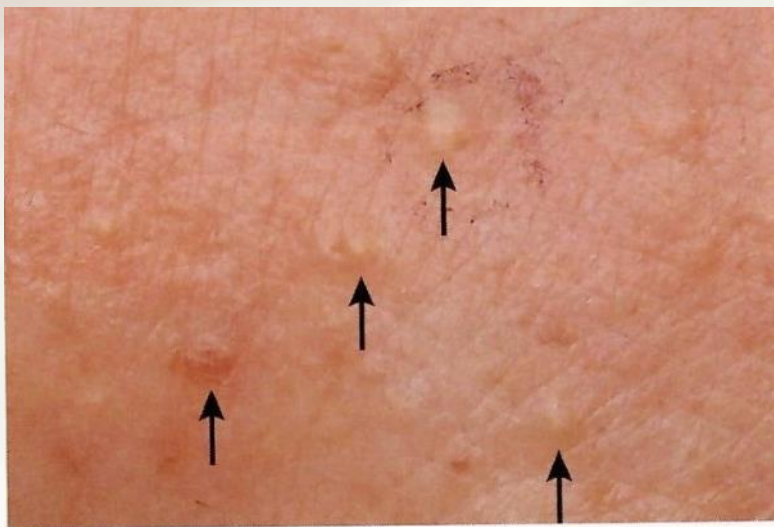


図 21.12 エクリン汗嚢腫 (eccrine hidrocystoma)



図 21.14 汗管腫 (syringoma)

a: 眼瞼に多発する 2～5 mm 大の扁平隆起性小丘疹. b: 額部. c: 腋窩に多発, 融合して大きな局面を形成している. d: 前胸部. e: 顔面に多発. 一部融合.



図 21.16 エクリン汗孔腫 (eccrine poroma)
暗赤色有茎性 (a) および広基性 (b) の小結節.

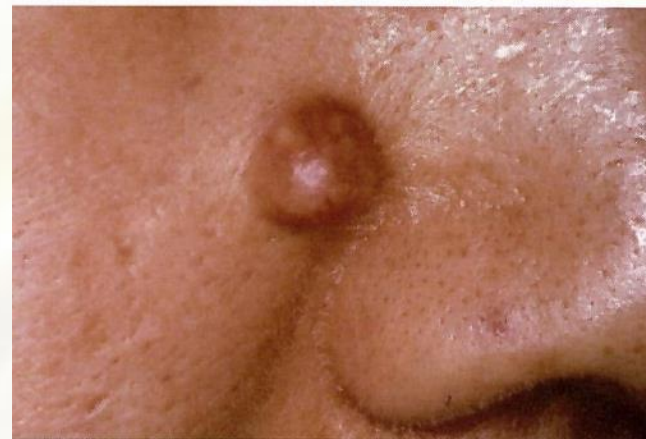
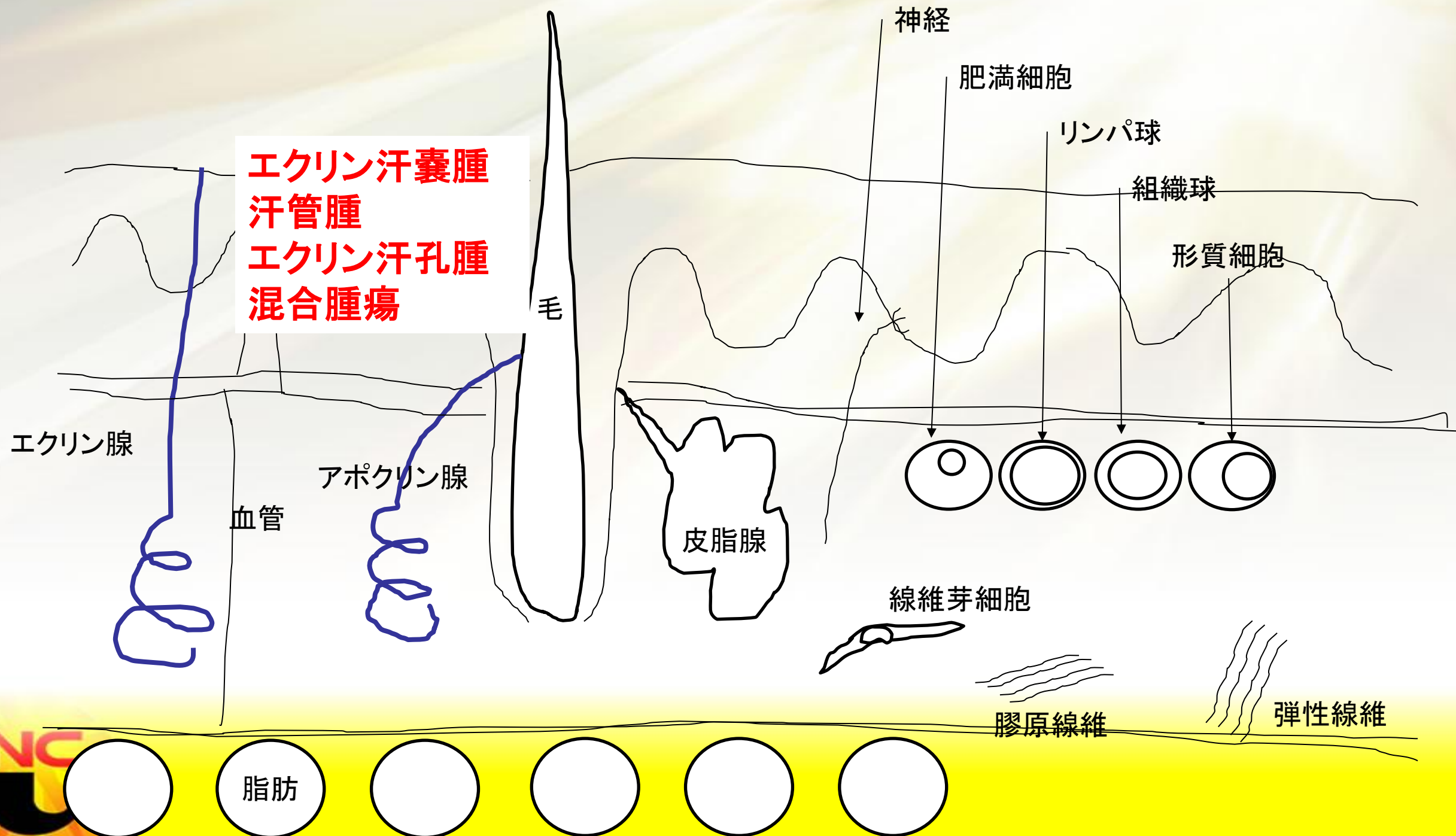


図 21.19 皮膚混合腫瘍 (mixed tumor of the skin)

エクリン汗囊腫
汗管腫
エクリン汗孔腫
混合腫瘍



汗孔腫, 汗管腫

診断

視診, 生検

エコー(皮下腫瘍)

治療

①手術療法

汗管腫

②レーザー療法(炭酸ガス, エルビウムYAG)

③高周波治療RF





図 21.33 神経線維腫 (neurofibroma)
隆起性の軟らかい皮膚腫瘍。



神経線維腫 神経鞘腫

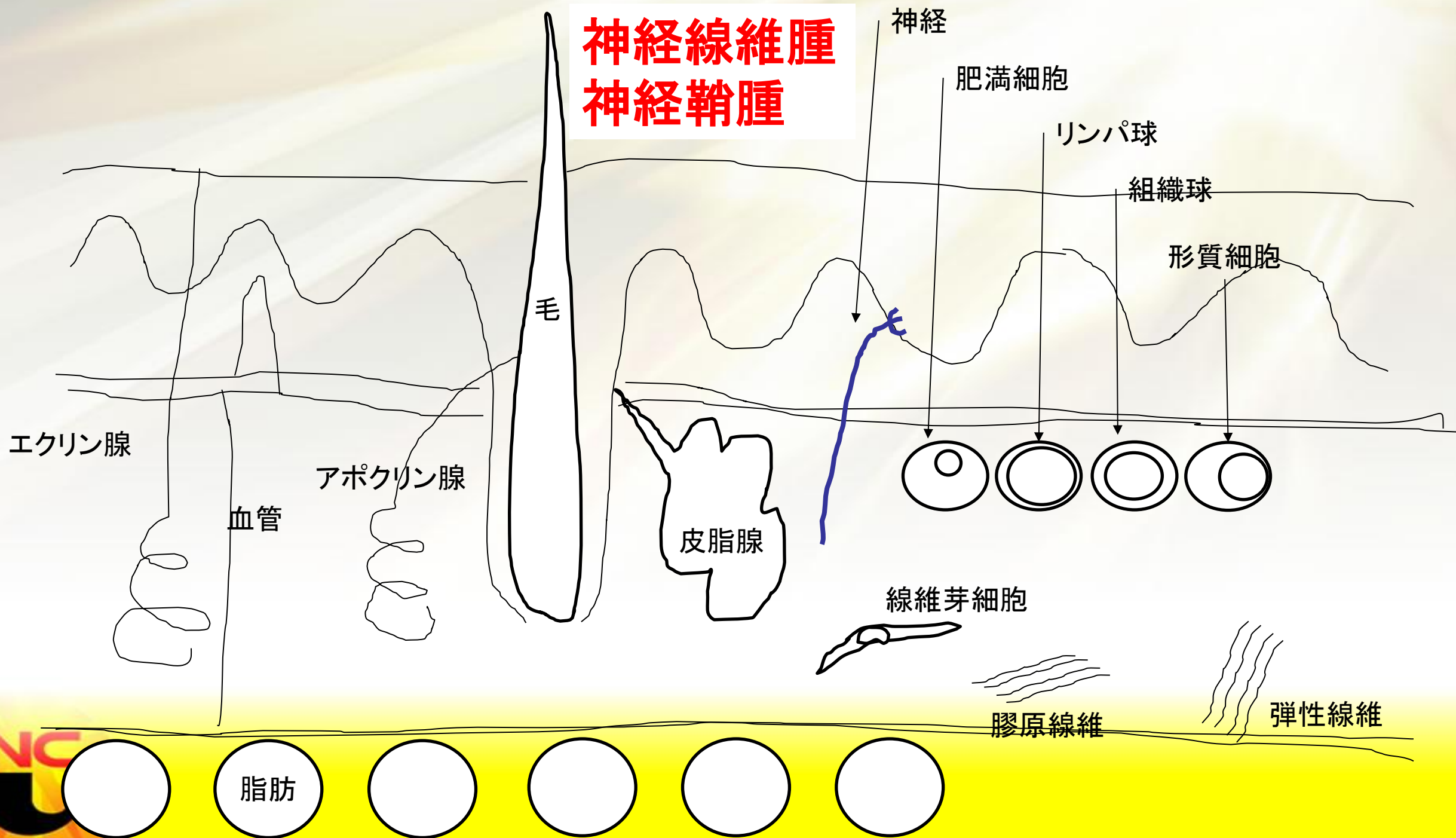




図 21.41① 化膿性肉芽腫 (pyogenic granuloma)
有茎性の鮮紅色から暗赤色の軟らかい腫瘤。



図 21.45① グロムス腫瘍 (glomus tumor)
爪下に形成。爪の変形を認める。激しい圧痛を伴う。

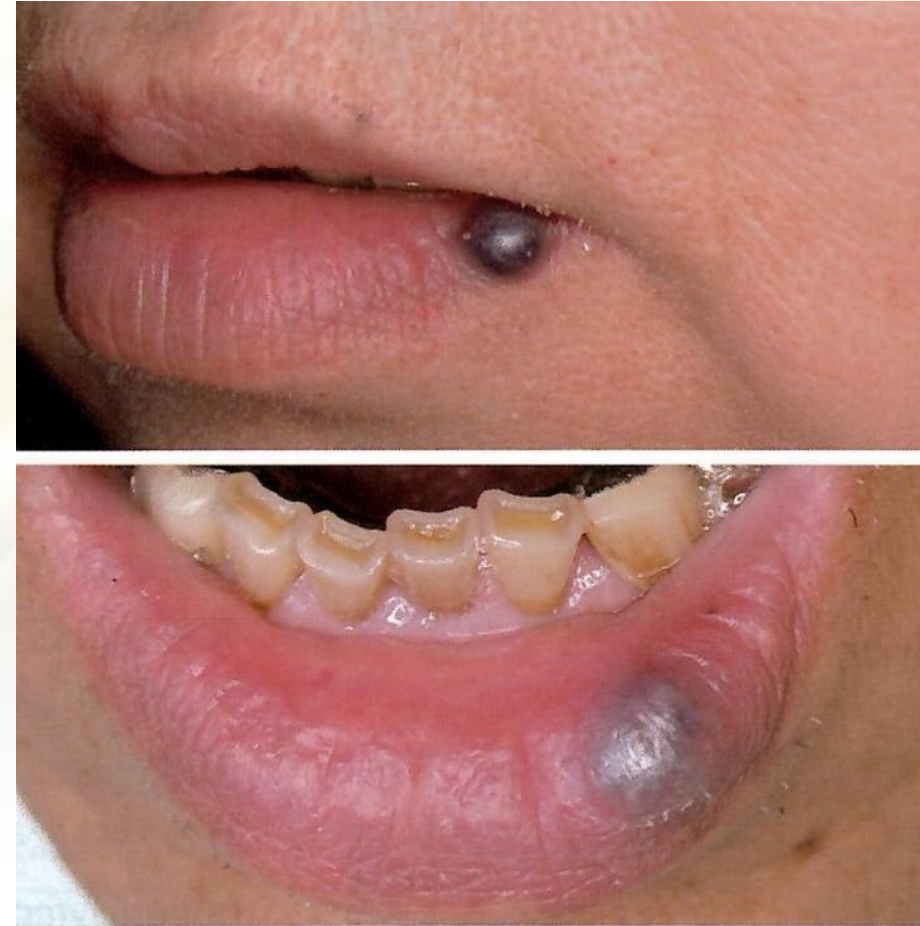
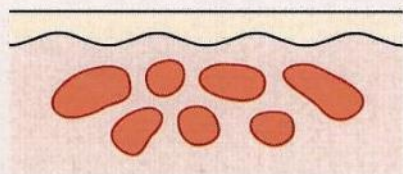


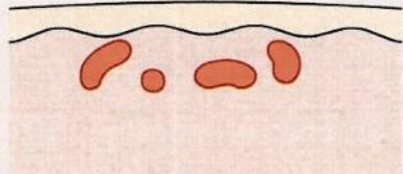
図 21.50 静脈湖 (venous lake)





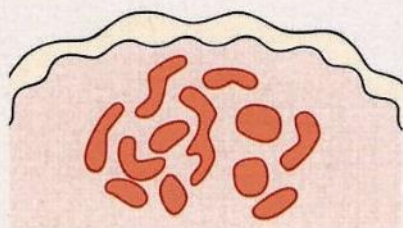
- 真皮浅層での毛細血管拡張
- 境界鮮明で隆起しない紅色斑
- 自然消退しない. 加齢に伴い色調増強, 顔面で病巣の肥厚をみる

毛細血管奇形



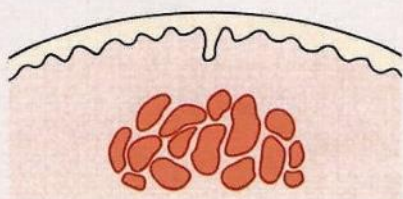
- 毛細血管の機能的な拡張
- 淡紅色の斑
- 額部・眼瞼部は2歳までに自然消退, 項部は自然消退しにくい

サーモンパッチ, Unna 母斑



- 血管内皮細胞の増殖
- 鮮紅色の腫瘍
- 自然消退するが瘢痕を残す

乳児血管腫



- 皮膚深層での奇形性小血管の増殖
- 軟らかい皮下腫瘍, 色調はさまざまで表面に小紅斑を伴う
- 自然消退しない

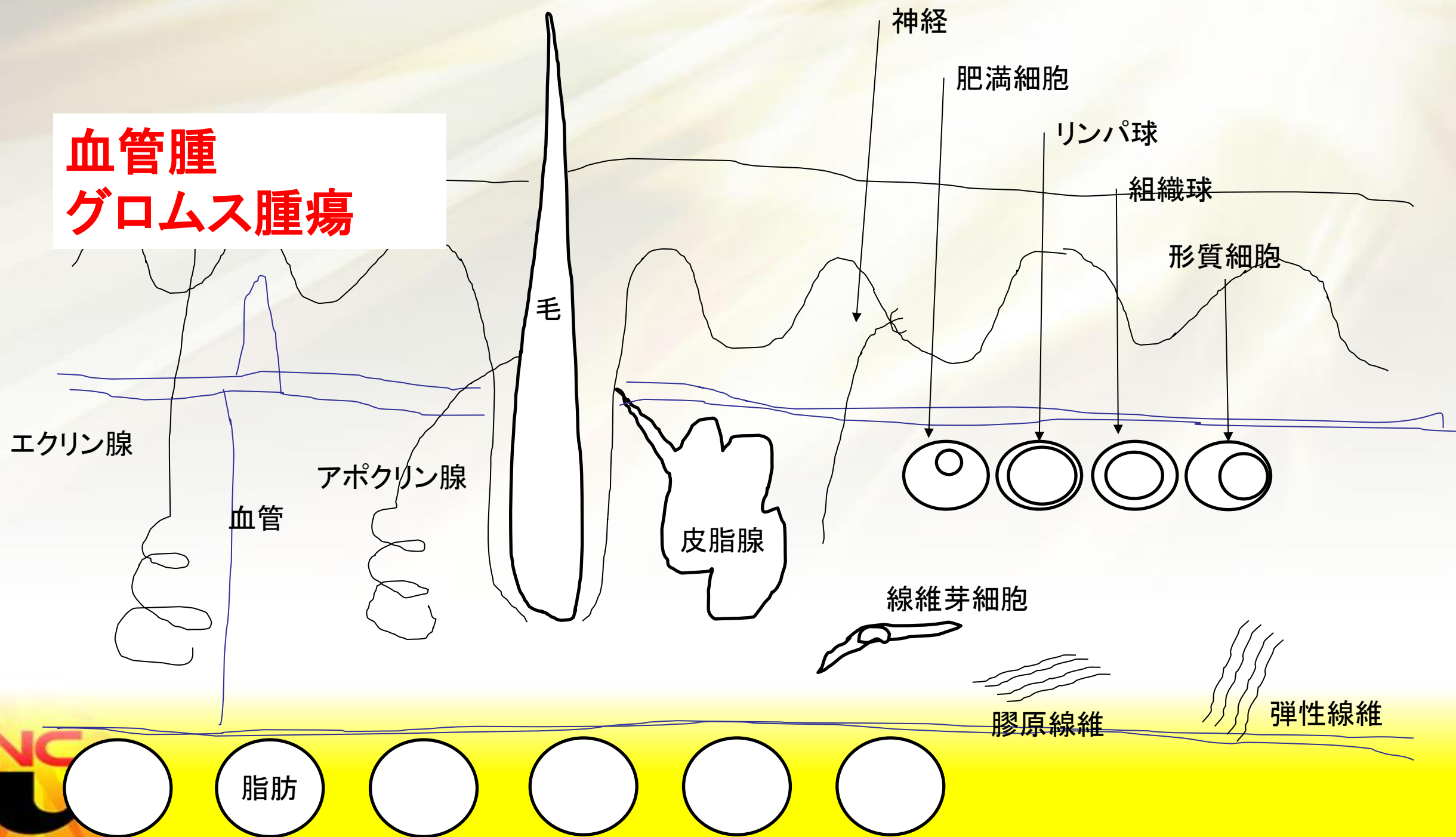
静脈奇形



図 21.37 乳児血管腫 (infantile hemangioma)

図 21.38 血管腫の分類

血管腫 グロムス腫瘍



診断

視診，生検

エコー（皮下腫瘍）

治療

①手術療法

血管腫

②レーザー療法（色素（ダイ）レーザー）

血管腫，グロムス腫瘍
静脈湖，血管拡張性肉芽腫





図 21.55 軟性線維腫 (soft fibroma)



図 21.56 皮膚線維腫 (dermatofibroma)



図 21.58 肥厚性瘢痕およびケロイド (hypertrophic scar and keloid)
a～c: 体幹に生じた例. d, e: 耳部のピアス後に生じた例.

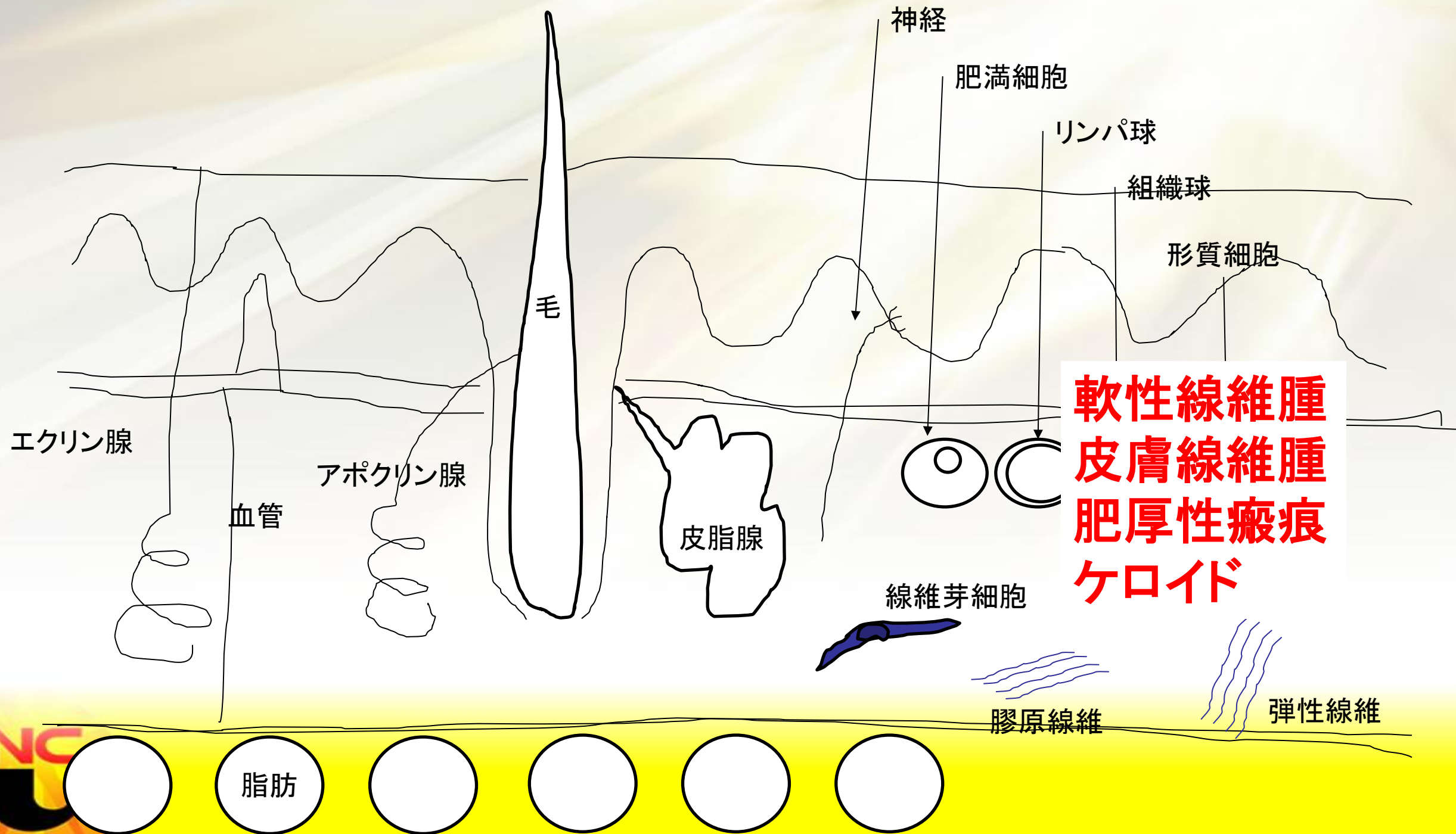




図 21.78① 肥満細胞症 (mastocytosis)



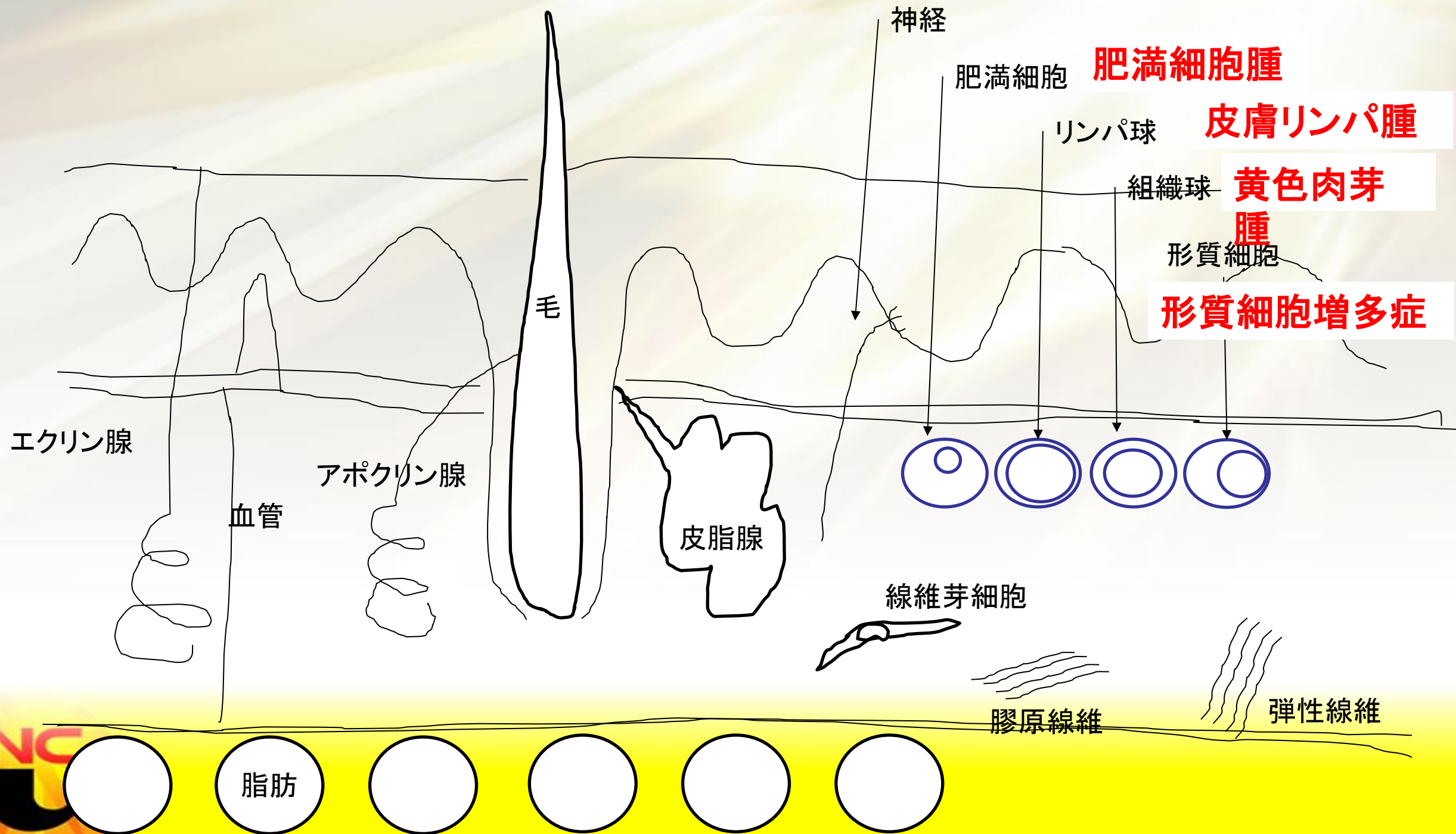
図 21.75 皮膚リンパ球腫 (lymphocytoma cutis)



図 21.67 黄色肉芽腫 (xanthogranuloma)



図 21.80 形質細胞増多症 (plasmacytosis)



第114回 医師国家試験 A41

- 1歳の男児。体幹の紅斑と色素斑を主訴に母親に連れられて来院した。生後4か月から入浴後に頸部と体幹に掻痒を伴う紅斑と膨疹が出現するようになったため受診した。
- 頸部と体幹に径2cm大までの色素斑と浸潤性紅斑の散在を認める。色素斑部を擦過すると数分後に膨疹を生じる。皮膚生検で真皮内にトルイジンブルー染色で赤紫色顆粒を含有する細胞の稠密な浸潤を認める。体幹の写真を別に示す。

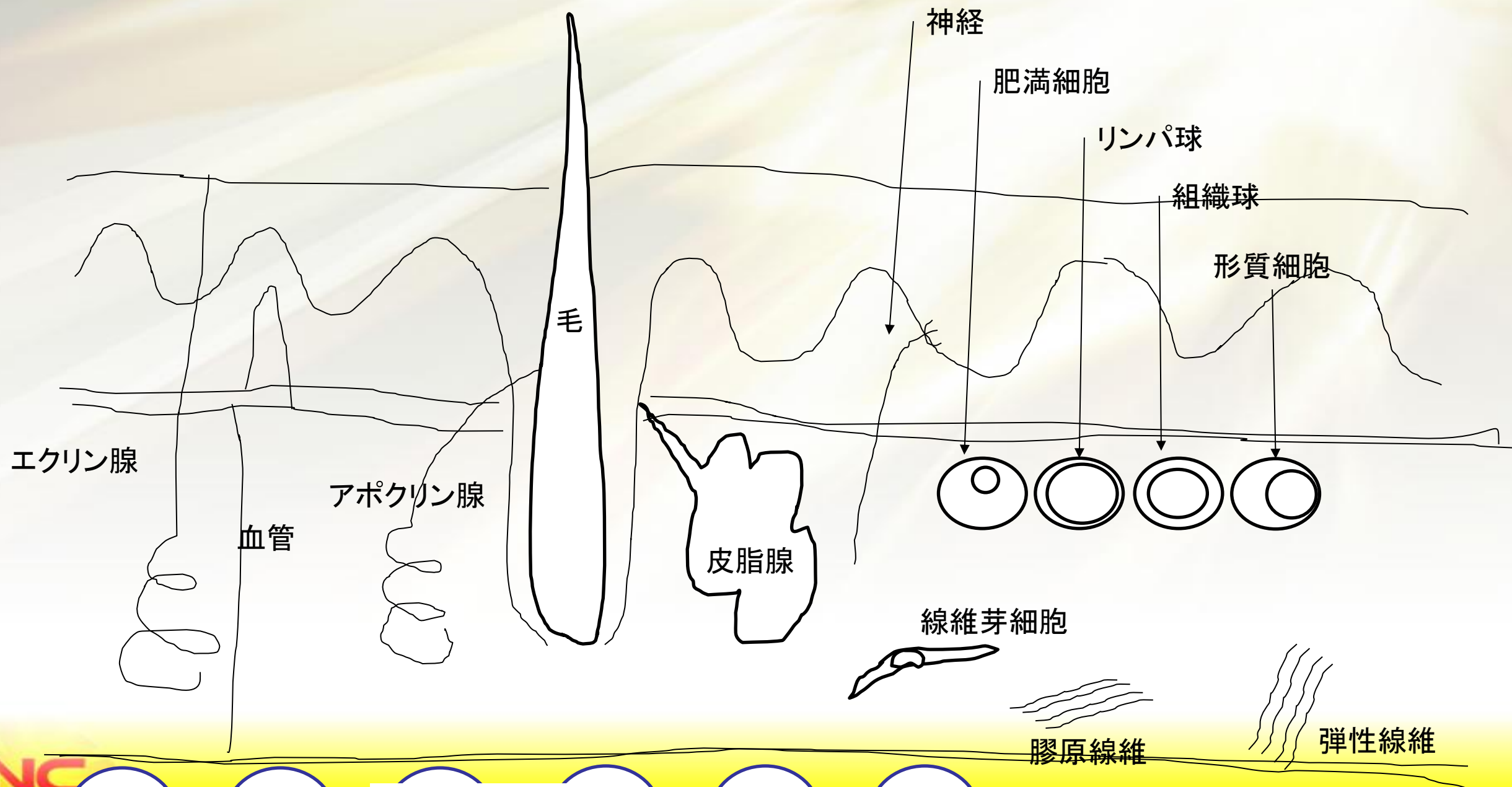
考えられる診断はどれか。

- a. Sweet病
- b. 急性痒疹
- c. Quincke浮腫
- d. 色素性蕁麻疹
- e. アトピー性皮膚炎





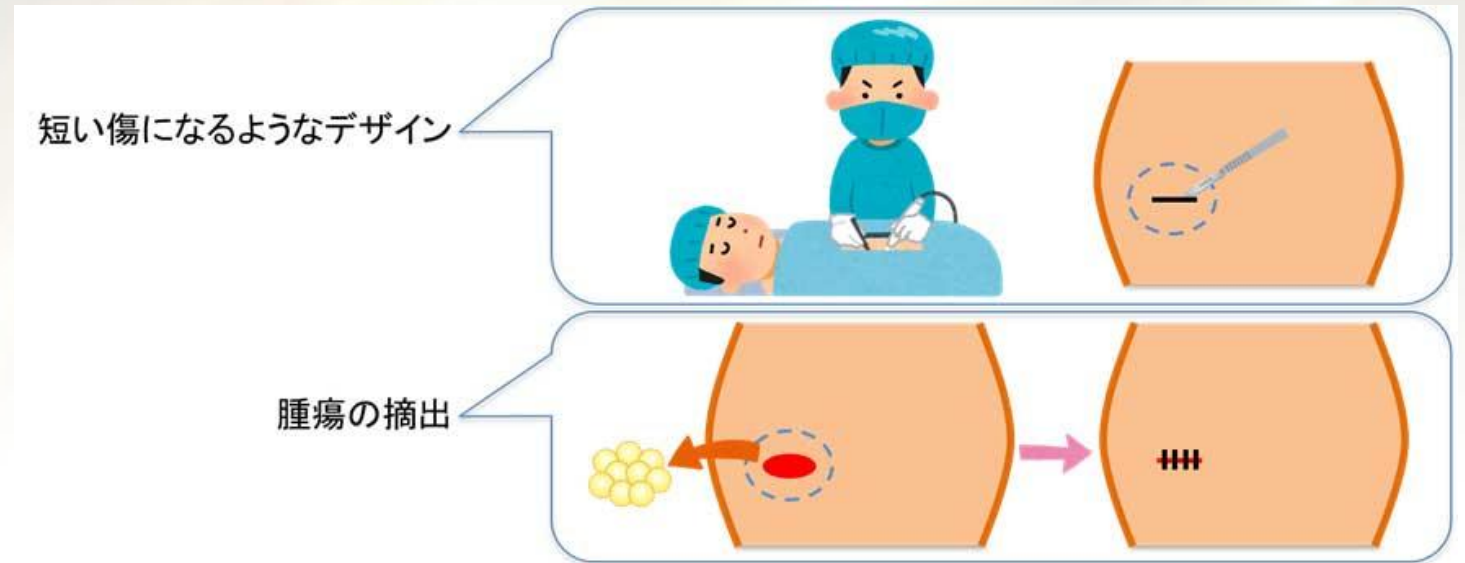
図 21.72 腫 (lipoma)



脂肪腫

診断
視診，エコー

治療
①手術療法



第114回 医師国家試験 114E19

- 触診上、皮膚表面が平滑なのはどれか。
- a. 脂肪腫
- b. Bowen 病
- c. 尋常性疣贅
- d. 脂漏性角化症
- e. ケラトアkantoma



囊腫 Cyst

良性腫瘍のひとつ

腫瘍細胞

+

產生される何か
角質
粘液
毛



図 21.27 稗粒腫 (milia)



図 21.25 類表皮嚢腫 (epidermoid cyst)
a: 中心に黒点状の開口部を有する. b: 炎症性類表皮嚢腫周囲に発赤, 腫脹を伴っている.



図 21.30 多発性脂腺嚢腫 (steatocystoma multiplex)
前腕, 腋窩に多発する 5 ~ 10 mm 大までの皮内嚢腫.

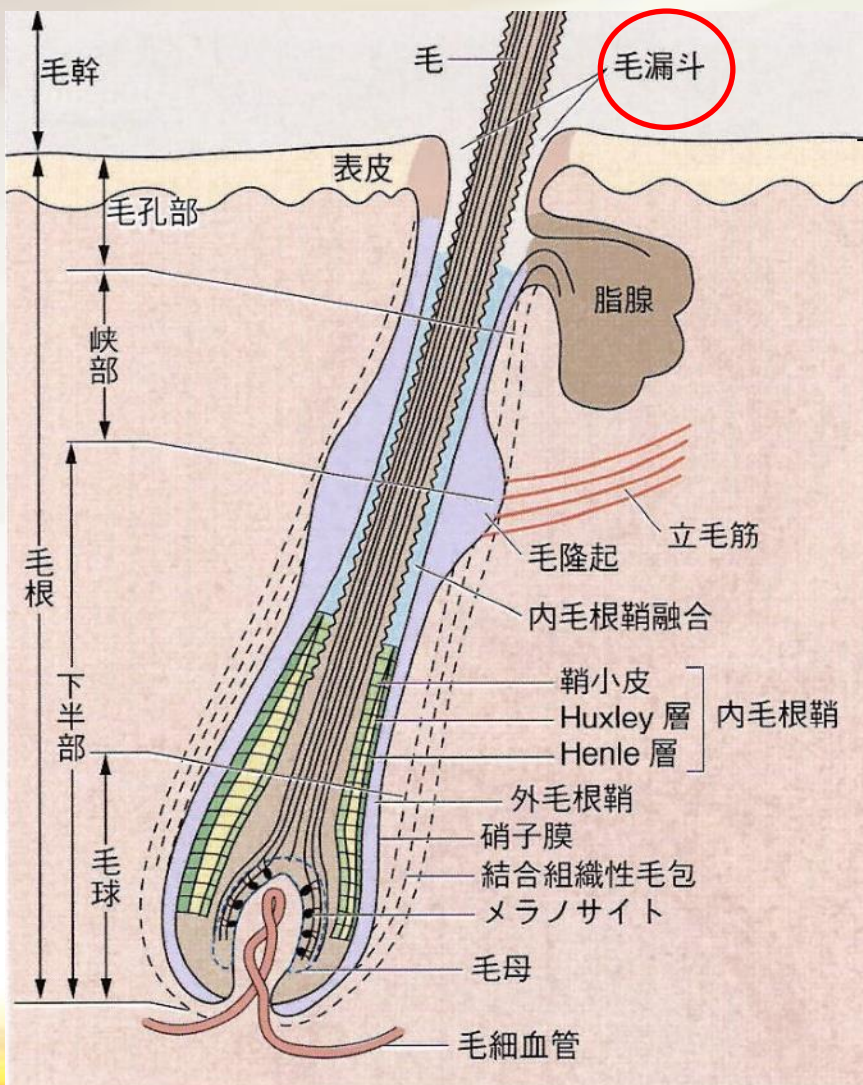


図 1.40 毛包縦断面



粉瘤
類表皮嚢腫
脂腺嚢腫

類表皮嚢腫
粉瘤(ふんりゅう)アテローマ
ということも多い

脂腺がついていると
脂腺嚢腫

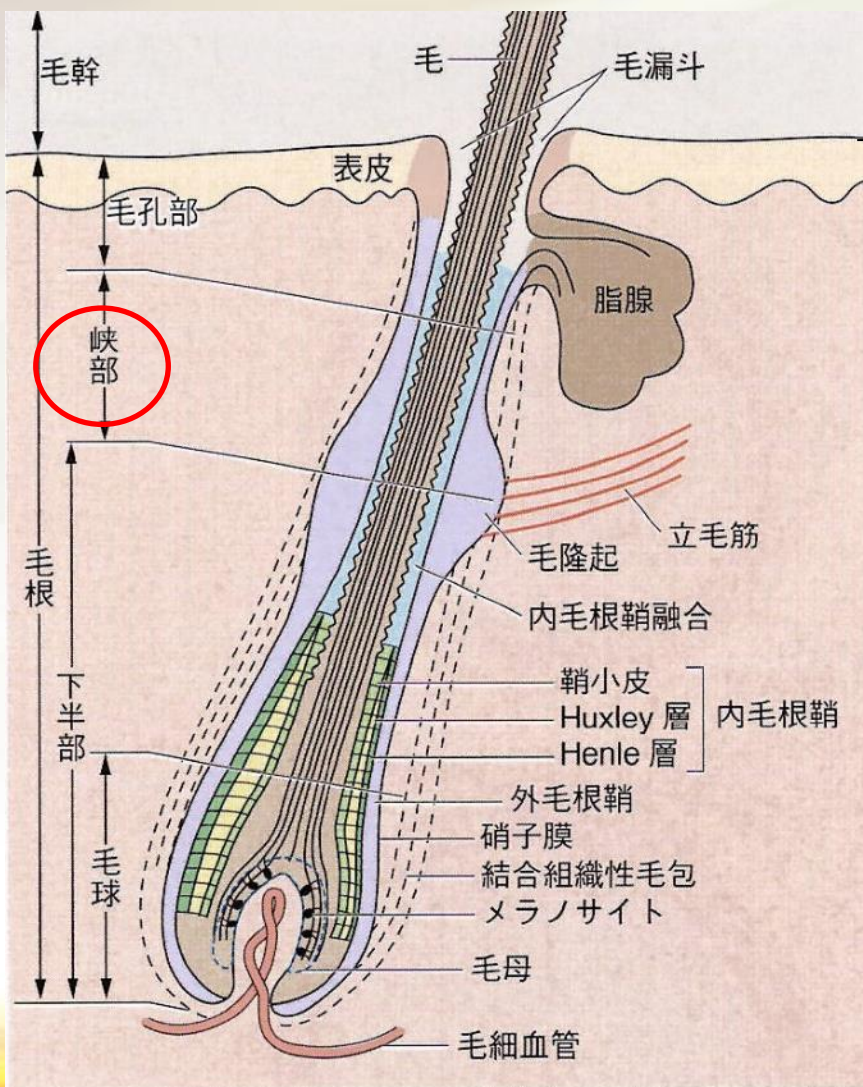
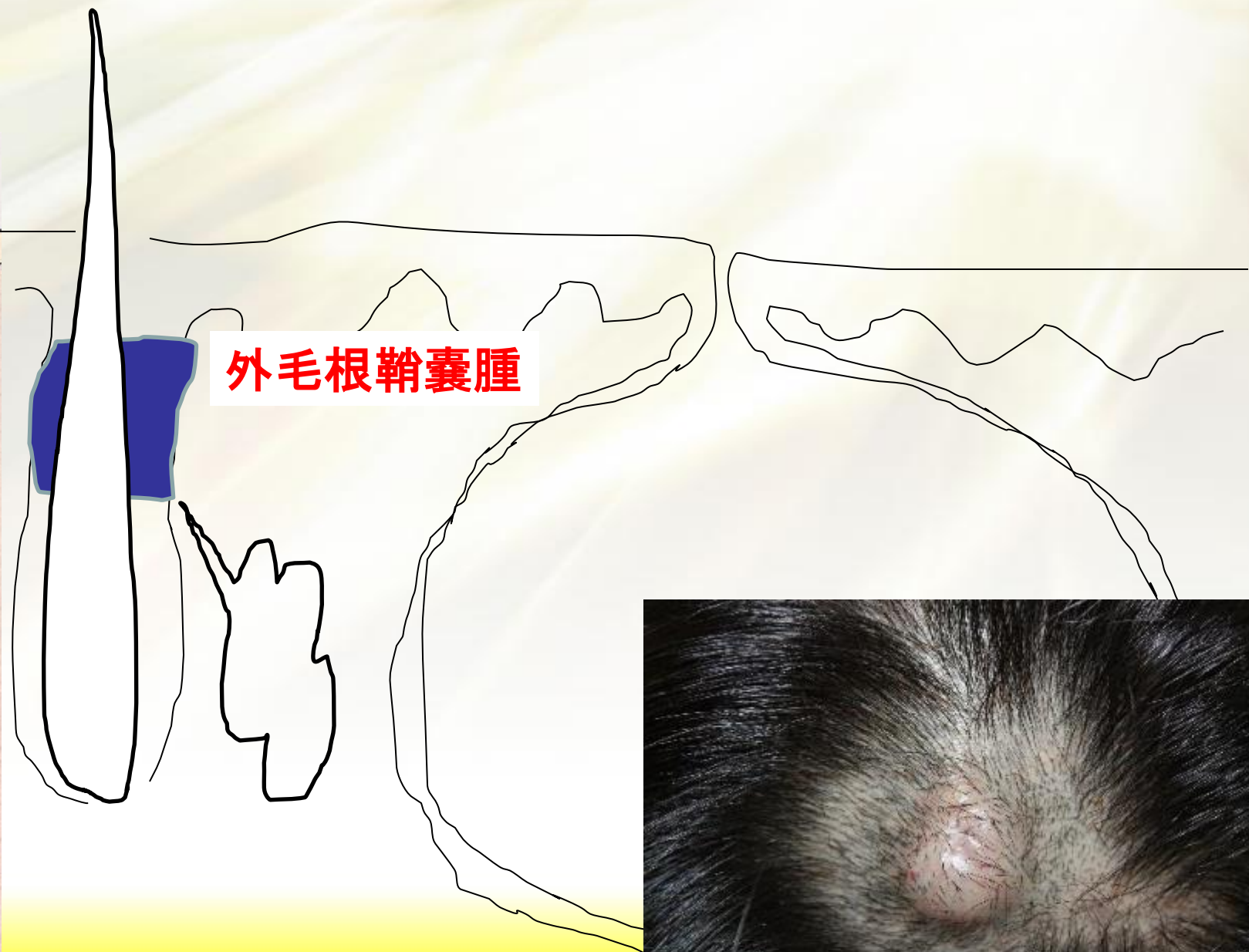


図 1.40 毛包縦断面



外毛根鞘囊肿



皮様嚢腫

表皮が角質を産生して
その他、皮脂腺、汗腺も増える

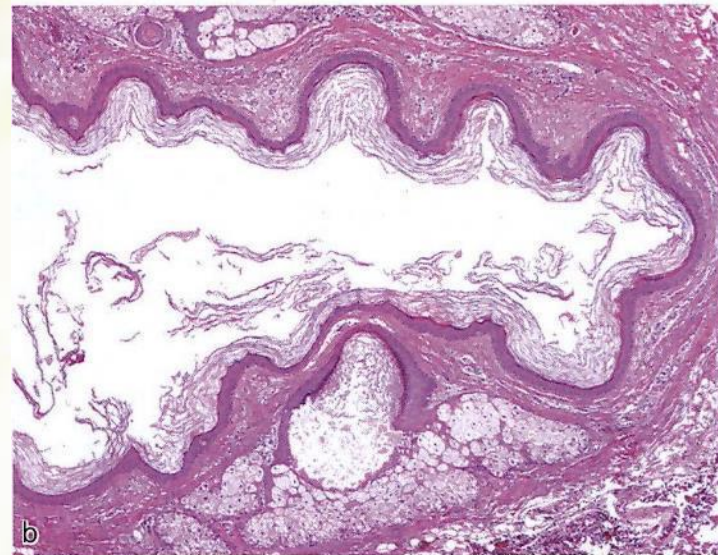
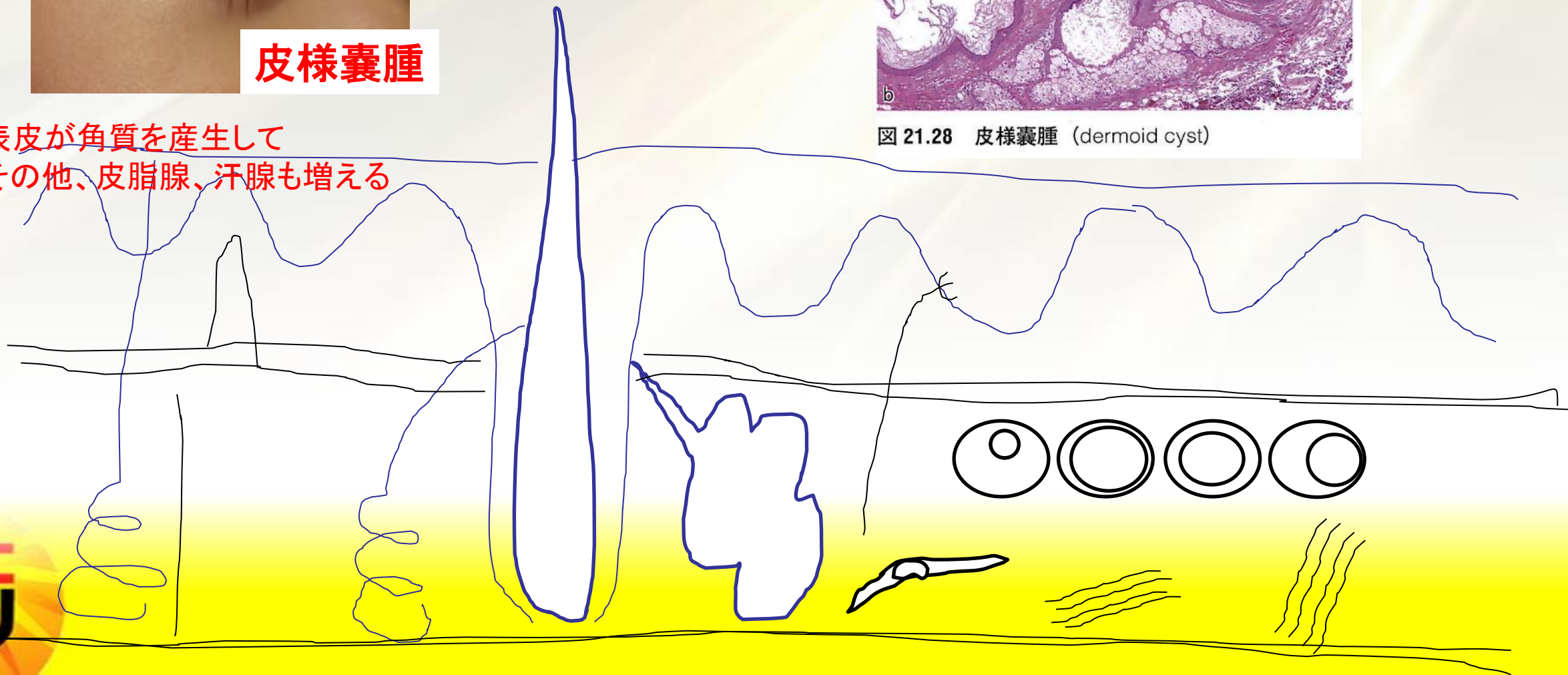
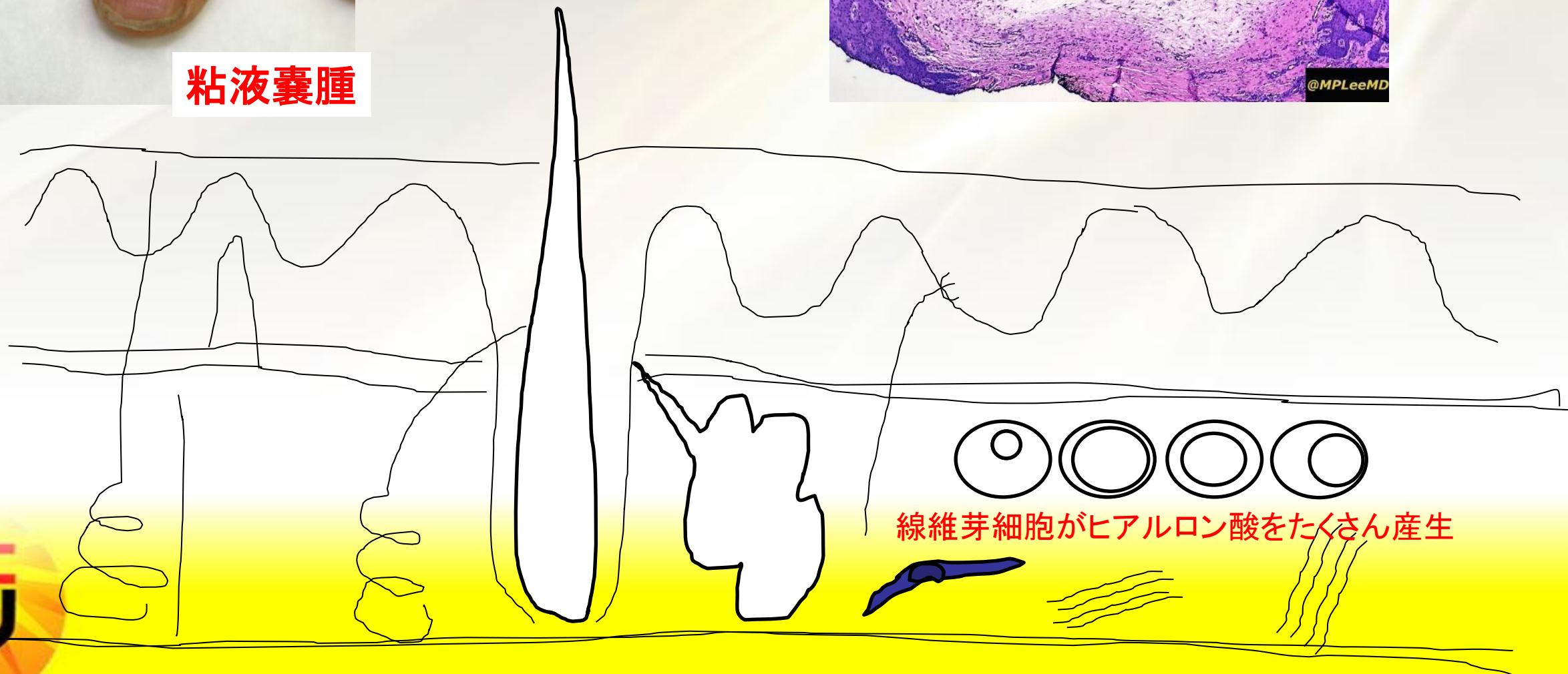
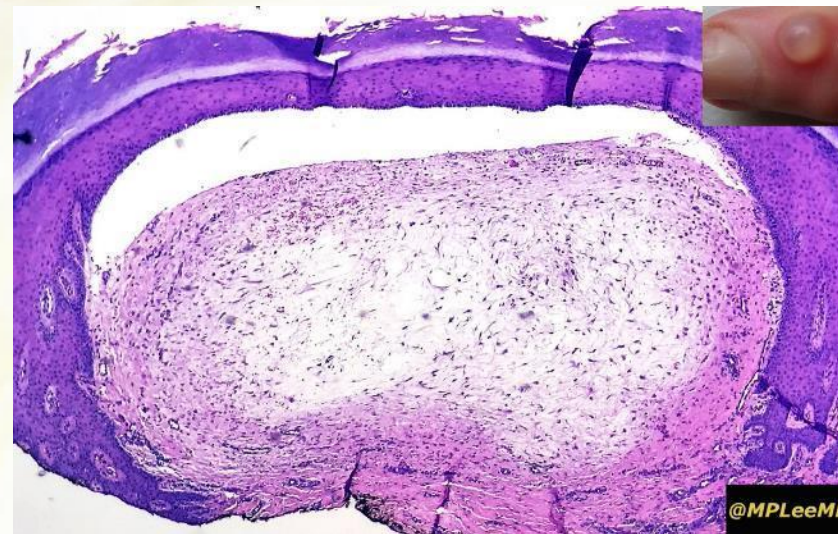


図 21.28 皮様嚢腫 (dermoid cyst)





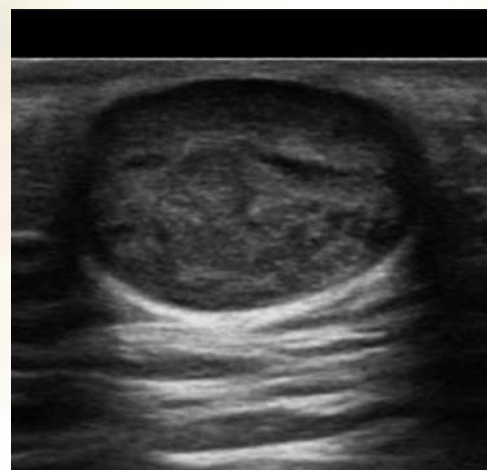
粘液嚢腫



診断
視診，生検
エコー

治療
①手術療法

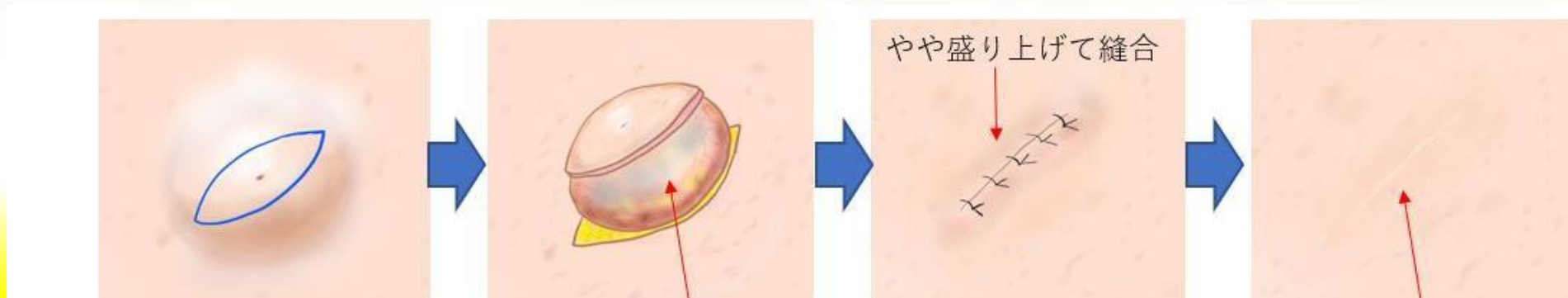
粉瘤，外毛根鞘囊肿 皮様囊肿，粘液囊肿



類表皮囊肿



粘液囊肿



第111回 医師国家試験 111E52

- 45歳の男性。2か月前から生じた右腋窩の皮疹を主訴に来院した。被覆皮膚と癒着し波動を触れる径 20 mm の皮疹が存在する。腋窩の写真と皮疹部の超音波像とを別に示す。
- この皮疹の種類はどれか。
 - a. 丘疹
 - b. 苔癬
 - c. 嚢腫
 - d. 膿疱
 - e. 膨疹

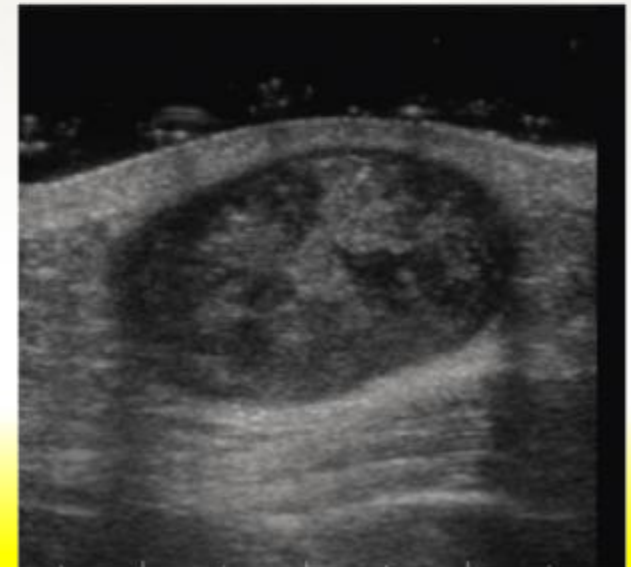




図 20.2② 母斑細胞母斑 (nevus cell nevus) *

ほくろ＝母斑細胞母斑(色素性母斑)



母斑とは

簡単にいうと

「生まれた時に、すでにそこにあるか、
すでに潜んでいる、良性腫瘍」





図 20.18① 疣贅状表皮母斑 (verrucous epidermal nevus)



図 20.20 脂腺母斑 (sebaceous nevus)
被髪部の脂腺母斑および脱毛を認める。



母斑の名前

表皮母斑

脂腺母斑

副耳

副乳

平滑筋母斑

青色母斑

太田母斑

蒙古斑

母斑細胞母斑

もとの細胞、組織

表皮角化細胞

皮脂腺

軟骨細胞

乳腺

平滑筋

真皮メラノサイト

真皮メラノサイト

真皮メラノサイト

~~表皮メラノサイト~~ 母斑細胞



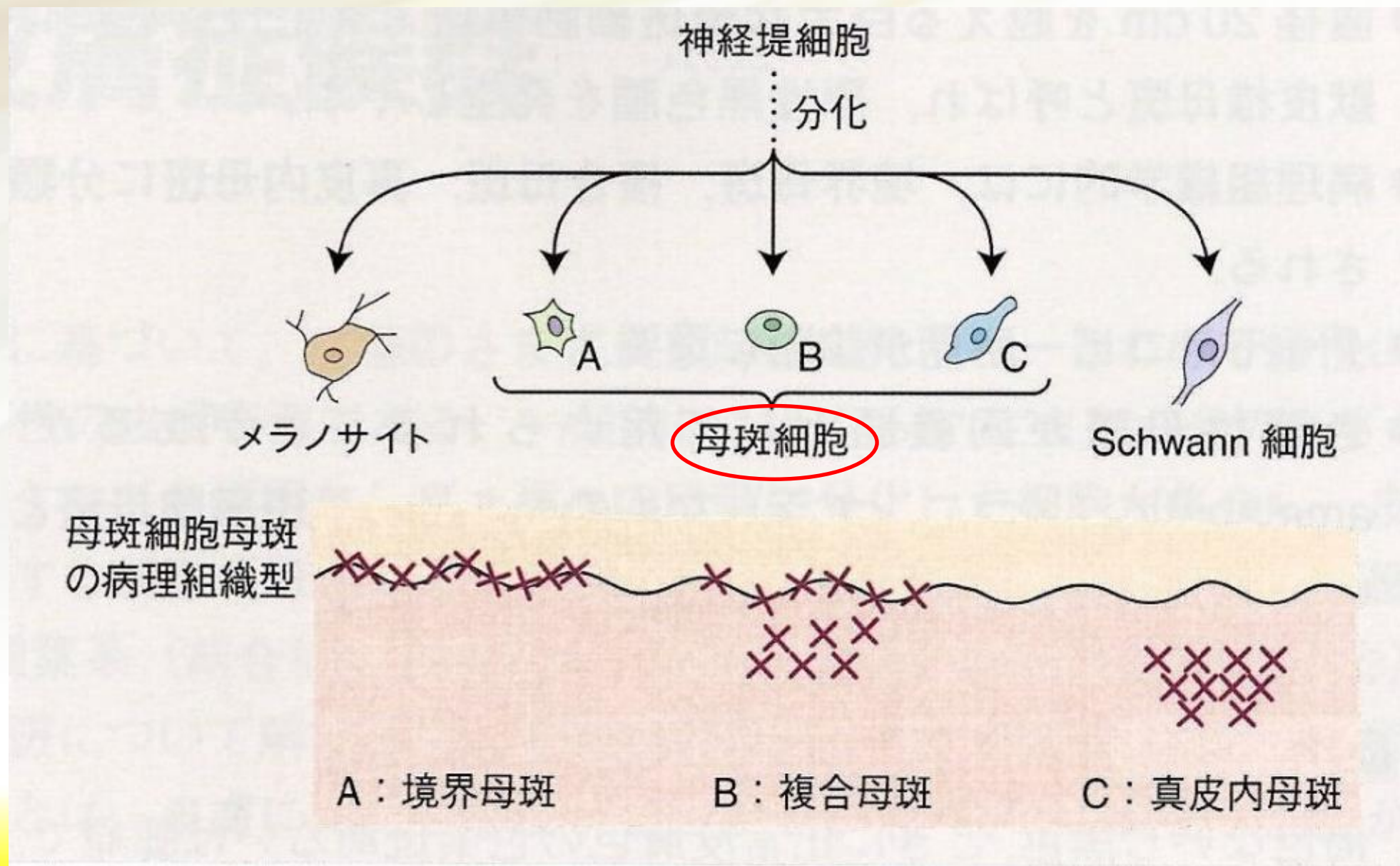


図 20.3 母斑細胞の起源および母斑細胞母斑の病理組織型

ほくろとは

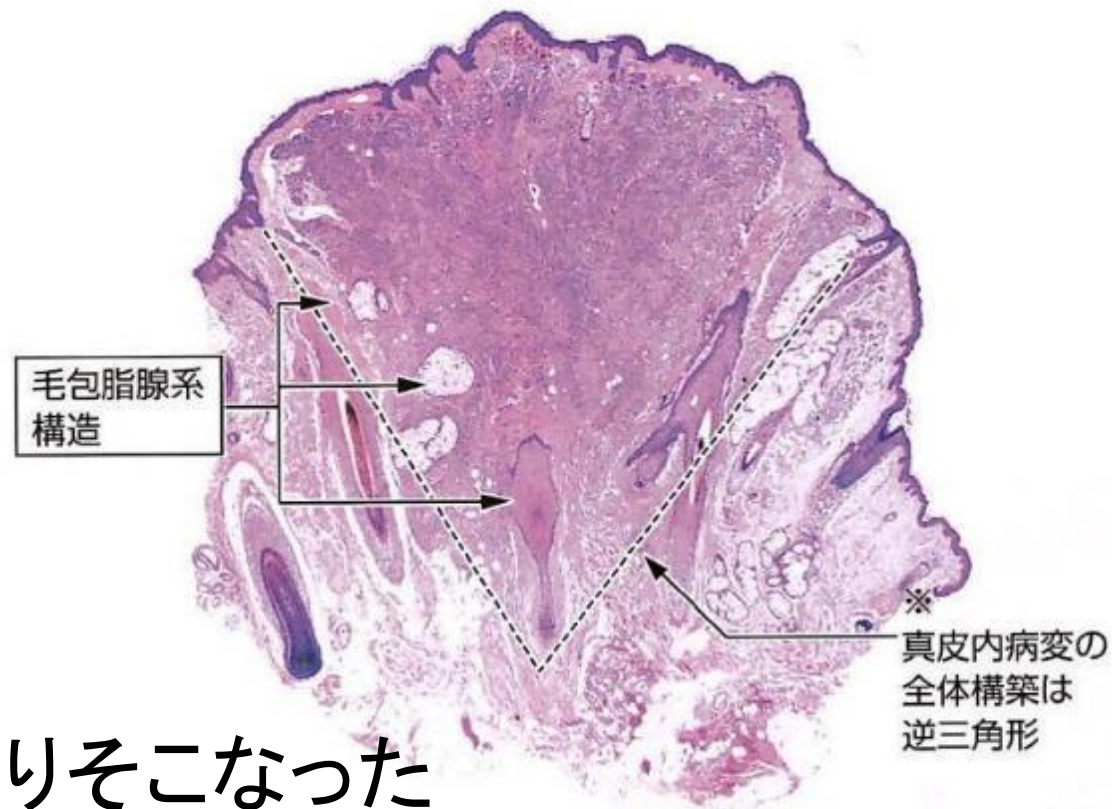
メラノサイトやシュワン細胞になりそこなった
母斑細胞の集まり

↓

徐々にメラニンを作るため、増えたように見える

↓

徐々に細胞増殖するので、盛り上がってくる



Miescher母斑(真皮[内]型)

診断

視診, ダーモスコピー, 生検



©MEDIC MEDIA

治療

①手術療法

②レーザー療法(炭酸ガス)



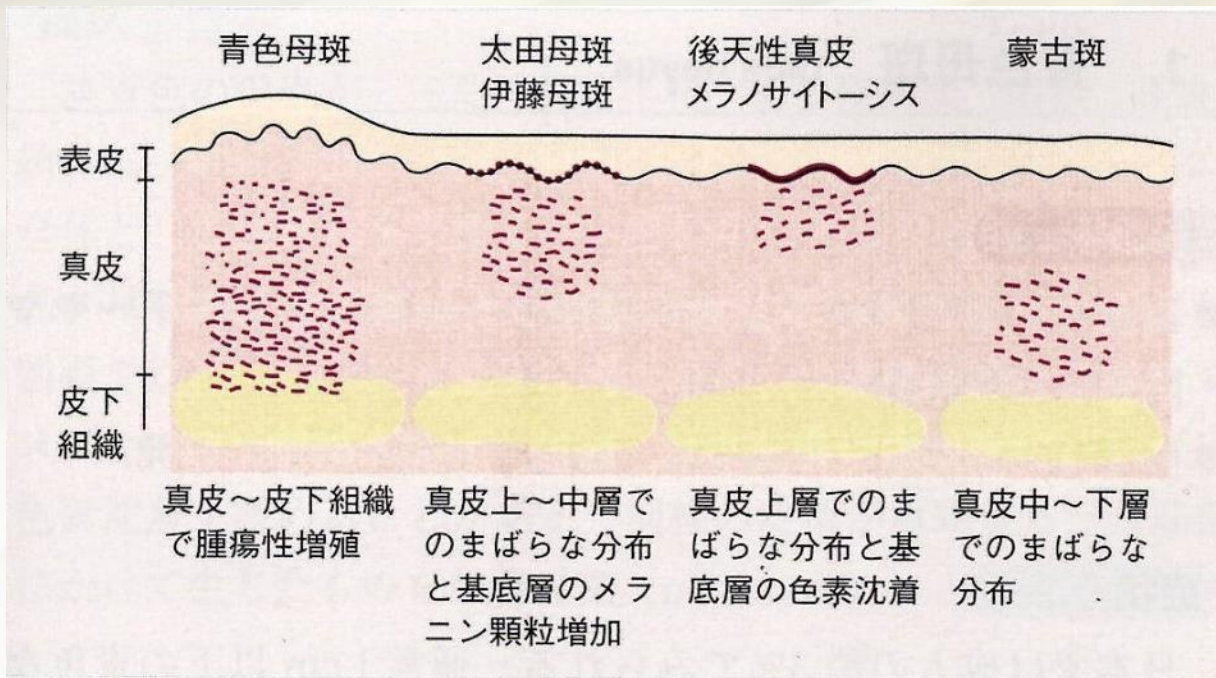


図 20.10 真皮メラノサイト系母斑の分類とメラノサイトの分布様式



図 20.11 青色母斑 (blue nevus)



図 20.13① 太田母斑 (nevus of Ota)



図 20.15 異所性蒙古斑 (aberrant mongolian spot)

a: 通常みられる腰殿部を越えて、上背部や肩に蒙古斑が拡大している。b: 前額部。c: 背部。



図 20.8 Spitz 母斑 (Spitz nevus)

a ~ d, f: 臨床像。e: d のダーモスコピー所見。g: f のダーモスコピー所見。

太田母斑，蒙古斑

診断

視診，生検



治療

①レーザー療法（Qスイッチアレキサンドライト
Qスイッチルビー）

第113回 D問題 3問目 - 113D03

真皮メラノサイトが増生しているのはどれか。

- a. 太田母斑
- b. 表皮母斑
- c. 扁平母斑
- d. 色素性蕁麻疹
- e. café au lait 斑



神経皮膚症候群(母斑症)

母斑が皮膚以外の臓器にもみられる全身性疾患

1. 神経線維腫症1型 von Recklinghausen病 NF1
 2. 神経線維腫症2型 NF2 耳鼻科で勉強
 3. 結節性硬化症 Bourneville - Pringle病
 4. Peutz-Jeghers症候群 消化器内科で勉強
 5. 色素失調症 Bloch-Sulzberger 症候群
 6. Sturge-Weber 症候群
- ...メジャーなもの6つ!



①カフェオレ斑
≡扁平母斑
出生時からある

②神経線維腫
学童期から多発

ニューロフィブロミン
の遺伝子変異

常染色体優性遺伝

予後良好



図 20.33 NF1 にみられるカフェオレ斑 (café-au-lait spot)

a: 大型のカフェオレ斑. b: 雀卵斑様色素斑の多発. c: 多発するカフェオレ斑. 大型の色素斑に硬毛を伴うこともある.



図20.34 NF1にみられる神経線維腫 (neurofibroma)



図 20.35 びまん性 (蔓状) 神経線維腫 (diffuse plexiform neurofibroma, pachydermatocoele)

a: 左乳房. b: 体側部. 縫縮手術により一部除去している.

ことになる.

びまん性や末梢神経内の神経線維腫から悪性末梢神経鞘腫瘍 (malignant peripheral nerve sheath tumor) を生じることがある.

③その他の皮膚病変

貧血母斑 (p.390 参照) やゲロムス腫瘍 (21 章 p.426 参照) がみられることがある. 幼児の顔面および頭部に黄色肉芽腫 (21 章 p.436 参照) を生じることがある.

④その他の症状

脳神経および脊髄神経の神経線維腫, 神経膠腫などがときにみられ, 痙攣発作や精神遅滞などを生じうる. 骨格異常も本症に特徴的であり, 脊柱変形 (側彎が多い), 胸郭変形, 四肢骨変形 (先天性脛骨偽関節症), 頭蓋骨欠損などをみる. 眼では Lisch 結節と呼ばれる虹彩小結節が特徴的 (図 20.36) で, 視神経膠腫も生じうる. そのほか, 褐色細胞腫や消化管腫瘍を生じることがある.

分類

神経線維腫症 (NF) は臨床的に 8 型 (NF1 ~ 8) に分類される. 本症は最も頻度が高く約 3,000 出生に 1 例の割合で生じる. 常染色体優性遺伝形式であるが, 半数以上は突然変異による孤発例である. NF2 は現在では別の疾患であることが判明しているため別項で記載する. 本症が身体の一部に分節状に生じることもあり (NF5), モザイクによるものと考えられる.

顔面の血管線維腫 精神遅滞 てんかん の3徴候

TSC1/2の遺伝子 常染色体優性遺伝



- ①葉状白斑(乳児期から)
- ②顔面血管線維腫
- ③shagreen patch
粒起革(りゅうきかく)様皮膚
- ④Koenen(ケーネン)腫瘍



図 20.37② 結節性硬化症 (tuberous sclerosis)
粒起革様皮膚 (shagreen patch) と葉状白斑 (white leaf-shaped macules).



図 20.37① 結節性硬化症 (tuberous sclerosis)
顔面の血管線維腫 (angiofibroma).



図 20.38 爪囲線維腫 (periungual fibroma),
Koenen 腫瘍 (Koenen's tumor)



図 20.41② 色素失調症 (incontinentia pigmenti) の水疱期

水疱→疣状丘疹
→色素沈着→消退
と移り変わる

NEMO遺伝子

X染色体優性遺伝
(95%女児)

マーブルケーキ状の
色素沈着

メラノサイトが基底層
から真皮内へ脱落し、
メラノファージが生じ
ることを組織学的色
素失調という



図 20.45 Sturge-Weber 症候群 (Sturge-Weber syndrome)

顔面の毛細血管奇形
眼病変

脳神経症状 3徴

三叉神経1, 2枝に単
純性血管腫

緑内障

牛眼(黒目が大きい)

GNAQ遺伝子

遺伝性はない

第111回 医師国家試験 - 111A02

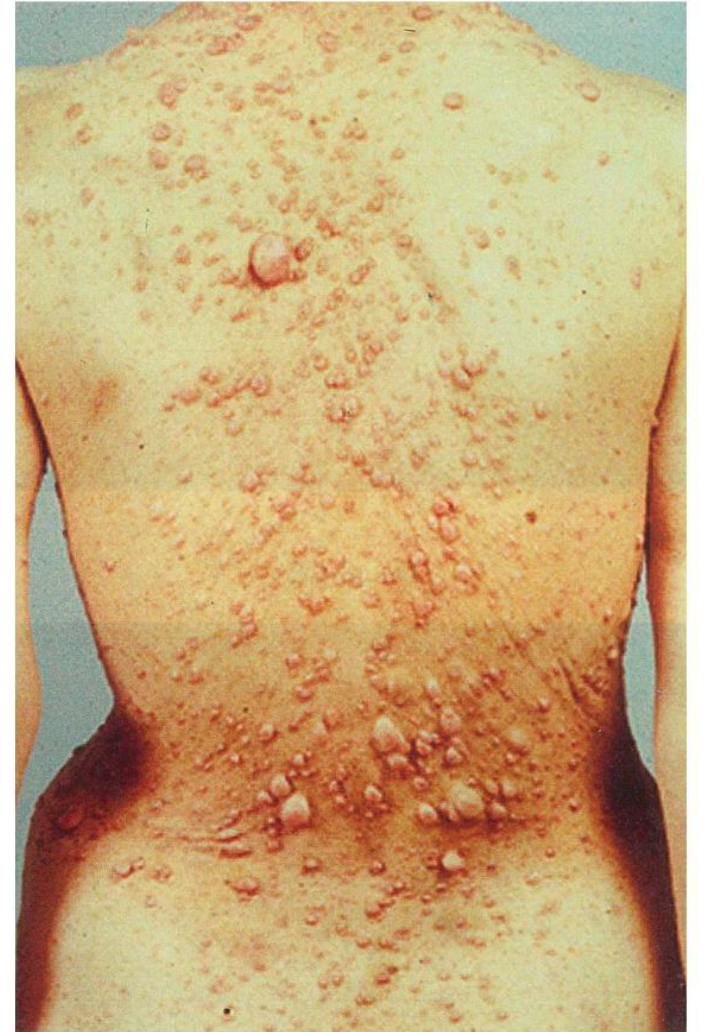
- 神経線維腫症1型<von Recklinghausen 病>について正しいのはどれか。
- a. 聴神経腫瘍を合併する。
- b. 脊椎の変形は幼児期から発症する。
- c. 神経線維腫は学童期以降に出現する。
- d. café au lait 斑は生後6か月以降に出現する。
- e. café au lait 斑の数と神経線維腫の数は相関する。



第98回 医師国家試験 - 98A6

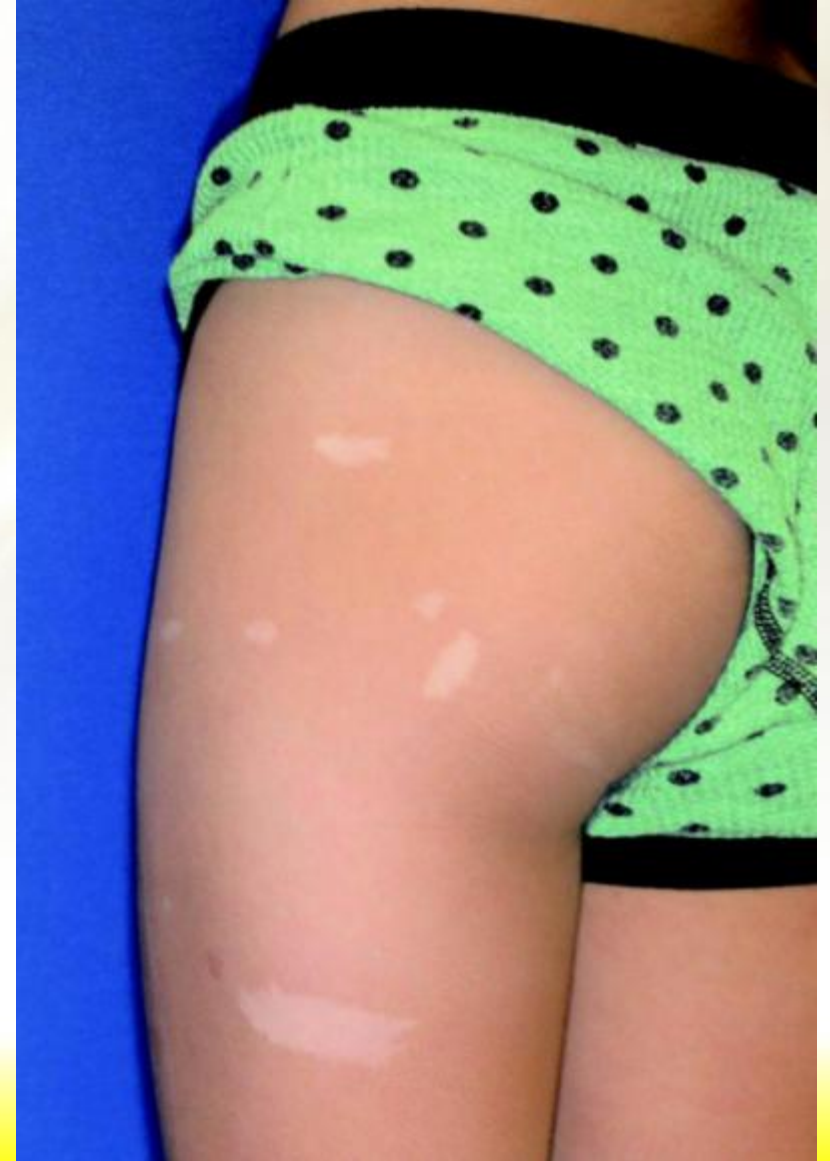
63歳の女性。幼少時から体幹や四肢に色素斑が多発していた。思春期ころから体幹と四肢とに軟らかい皮膚腫瘍が出現し、次第に数が増えてきた。体幹の写真を別に示す。
この皮膚腫瘍はどれか

- a, 脂肪腫
- b, リンパ管腫
- c, 神経線維腫
- d, 肥満細胞腫
- e, 海綿状血管腫



第114回 医師国家試験 114A36

- 4歳の男児。体幹の白斑を主訴に父親に連れられて来院した。生後5か月で体幹に白斑があるのを父親が発見した。その後、増数してきたため受診した。1歳時にけいれんの既往がある。受診時、臀部と大腿部を中心に大小の白斑を認める。顔面では鼻部中心に丘疹が散在している。大腿部の写真を別に示す。
- この患児で思春期以降に出現する可能性が高いのはどれか。
 - a. 脂腺母斑
 - b. 神経線維腫
 - c. 爪囲線維腫
 - d. 聴神経腫瘍
 - e. 単純性血管腫



第110回 医師国家試験 110A15

- 結節性硬化症で見られるのはどれか。2つ選べ。
- a. てんかん
- b. 脊柱側彎
- c. 聴覚障害
- d. 血管線維腫
- e. 性腺機能低下



第113回 医師国家試験 - 113F52

- 生後1か月の乳児。1か月健康診査のために両親に連れられて来院した。
在胎38 週、出生体重 2,998 g で出生した。Apgar スコアは 8点(1分)、9点(5分)であった。出生後は完全母乳栄養であり、本日の体重は 4,050 g である。四肢を活発に動かし、固視を認める。体幹や四肢に 2～3 cm の皮疹を7個認める。体幹部の皮疹を別に示す。父親には、鼻の周囲に多数の血管線維腫を認める。母親には皮疹を認めない。
- 両親への対応として適切なのはどれか。
 - a.「抗真菌薬を塗りましょう」
 - b.「心エコー検査を行いましょう」
 - c.「皮疹は自然に消失するでしょう」
 - d.「胸部エックス線写真を撮りましょう」
 - e.「皮疹が悪性化する可能性があります」

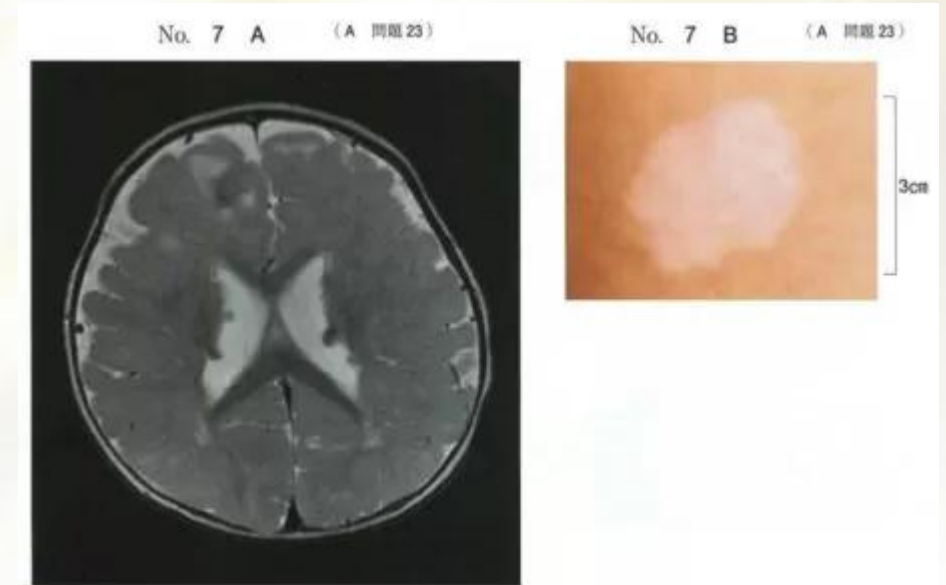


第119回 A問題 23問目 - 119A23

9か月の女児。けいれんを主訴に両親に連れられて来院した。生後5か月で腹部に皮疹があることに母親が気付いていた。2週間前から両上肢を伸展させ、しばしば頭部を前屈する動作が出現した。約5秒間隔で10回以上反復し、次第に頻度が増加して毎日みられるようになった。同時期からあやし笑いが乏しくなり、ひとり座りが不安定になった。

身長70.5 cm、体重8.2 kg。体温36.3℃。脈拍108/分、整。血圧82/48 mmHg。呼吸数32/分、SpO₂ 99% (room air)。心音と呼吸音に異常を認めない。腹部は平坦、軟で、肝・脾を触知しない。体幹と大腿部に皮疹を3個認める。頭部単純MRIのT2強調水平断像(別冊No.7A)と大腿部の皮疹の写真(別冊No.7B)を別に示す。

最も考えられる疾患はどれか。



1. 尋常性白斑
2. 結節性硬化症
3. 神経線維腫症1型
4. Sturge-Weber症候群
5. von Hippel-Lindau病

第115回 115A61

- 10か月の男児。無熱性けいれんを主訴に、父親に連れられて来院した。添い寝をしていたところ突然2分間の左上下肢の間代けいれんがみられたため来院した。出生時から右顔面にポートワイン様母斑を認めた。追視・固視2か月、定頸4か月、坐位保持7か月で発達の異常は指摘されていなかった。9か月時に1分間の左上下肢の間代けいれんがみられ、2週後に同様の発作があった。
- 頭部造影MRIで、右大脳の軟膜血管腫を認めた。
- この疾患で見られないのはどれか。
 - a. 片麻痺
 - b. 精神遅滞
 - c. てんかん
 - d. 網膜色素変性
 - e. 脳回に沿った石灰化

覚えておくべき疾患

- 脂漏性角化症(老人性疣贅)
- 汗孔角化症
- 毛包腫、毛母腫
- エクリン汗嚢腫、汗管腫、エクリン汗孔腫
- 神経線維腫、神経鞘腫
- 血管腫、グロムス腫瘍
- 軟性線維腫、皮膚線維腫、肥厚性瘢痕、ケロイド
- 脂肪腫
- 粉瘤、類表皮嚢腫、脂腺嚢腫

神経皮膚症候群(母斑症)

- 神経線維腫症1型(NF1)
- 結節性硬化症
- 色素失調症
- Sturge-Weber症候群

研修医さん、学生さん！ 皮膚科 BBQ 説明会

8月31日(日)

オープンエアーでおいしいものを食べよう！
おともだち同士でぜひ誘い合って遊びに来てね★

完全無料、手ぶらでOK！



時間 集合 8:45 出発 9:00

場所 集合:名市大本部棟前 開催:三河高原キャンプ村(豊田市)

少しでも興味を持ってくれた方は
こちらまで連絡を

✉ hihuka@med.nagoya-cu.ac.jp

☎ 0528538261 or 内線 8261

